ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

Libro Gordo

CARDIOLOGÍA

90 preguntas de práctica

Sistema Cardiovascular

MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Cardiología · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
BLOQUE 1: ARRITMIAS, CONDUCCIÓN & URGENCIAS ELÉCTRICAS					
1.01.1.002	Bradicardias Sintomáticas & Bloqueos AV (GES Marcapasos)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q15, Q16, Q17	Tomo 01 · 1.8 (Pág. 19)
1.01.1.012	Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q6, Q7, Q8	Tomo 01 · 1.4 (Pág. 11)
1.01.1.013	Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q7, Q8, Q9	Tomo 01 · 1.4 (Pág. 11)
1.01.1.014	Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q7, Q8, Q10	Tomo 01 · 1.4 (Pág. 11)
1.01.1.024	TPSV & Síndrome de Wolff-Parkinson-White	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q11, Q12, Q13	Tomo 01 · 1.6 (Pág. 15)
1.01.2.006	Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q3, Q4, Q5	Tomo 01 · 1.2 (Pág. 7)
1.01.2.008	TPSV & Síndrome de Wolff-Parkinson-White	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q12, Q13, Q14	Tomo 01 · 5.6 (Pág. 99)
1.01.2.009	Bradicardias Sintomáticas & Bloqueos AV (GES Marcapasos)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q16, Q17, Q18	Tomo 01 · 1.7 (Pág. 17)
1.01.3.001	Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q7, Q8	Tomo 06 · 5.6 (Pág. 81)
1.01.3.002	Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q4, Q5	Tomo 19 · 19.21 (Pág. 32)
1.01.3.004	Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q4, Q5	Tomo 06 · 5.6 (Pág. 81)
1.01.4.001	Lectura Sistemática del ECG en Urgencias y APS	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q1, Q2	Tomo 01 · 2.2 (Pág. 30)
BLOQUE 2: CARDIOPATÍA CORONARIA & SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS					
1.01.1.001	Angina Crónica Estable & Estratificación de Riesgo Funcional	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q19, Q20, Q21, Q22, Q23, Q24, Q25	Tomo 01 · 2.2 (Pág. 30)
1.01.1.008	Complicaciones Mecánicas del IAM & Angina de Prinzmetal	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q33, Q34, Q35	Tomo 01 · 4.4 (Pág. 72)
1.01.1.009	Complicaciones Mecánicas del IAM & Angina de Prinzmetal	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q34, Q35, Q36	Tomo 01 · 4.2 (Pág. 68)
1.01.1.020	SCASEST: Angina Inestable e IAM sin Supradesnivel del ST	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q26, Q27, Q28	Tomo 01 · 3.5 (Pág. 57)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.01.1.025	Complicaciones Mecánicas del IAM & Angina de Prinzmetal	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q34, Q35	Tomo 01 · Cardiología (Pág. 8)
1.01.2.001	SCASEST: Angina Inestable e IAM sin Supradesnivel del ST	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q27, Q28, Q29	Tomo 01 · 2.4 (Pág. 34)
1.01.2.002	SCACEST: IAM con Supradesnivel del ST & Protocolo Reperfusión GES	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q30, Q31, Q32	Tomo 01 · 5.7 (Pág. 101)
1.01.3.003	SCACEST: IAM con Supradesnivel del ST & Protocolo Reperfusión GES	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q31, Q32	Tomo 01 · 1.5 (Pág. 13)
BLOQUE 3: INSUFICIENCIA CARDÍACA, MIOCARDIOPATÍAS & SHOCK					
1.01.1.006	Insuficiencia Cardíaca Crónica: Fenotipos, Diagnóstico & Criterios Framingham	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q37, Q38, Q39, Q41, Q42	Tomo 01 · 5.9 (Pág. 105)
1.01.1.007	Insuficiencia Cardíaca Crónica: Fenotipos, Diagnóstico & Criterios Framingham	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q38, Q39, Q40, Q41, Q42	Tomo 01 · 4.7 (Pág. 80)
1.01.1.016	Miocardiopatías (Hipertrófica, Dilatada, Restrictiva & Miocarditis)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q50, Q51	Tomo 01 · 5.3 (Pág. 93)
1.01.1.017	Miocardiopatías (Hipertrófica, Dilatada, Restrictiva & Miocarditis)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q51, Q52	Tomo 01 · 4.3 (Pág. 70)
1.01.1.018	Miocardiopatías (Hipertrófica, Dilatada, Restrictiva & Miocarditis)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q51, Q53	Tomo 01 · 3.1 (Pág. 45)
1.01.1.019	Miocardiopatías (Hipertrófica, Dilatada, Restrictiva & Miocarditis)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q51, Q54	Tomo 01 · 4.5 (Pág. 76)
1.01.2.003	Shock Cardiogénico & Diagnóstico Diferencial de los 4 Shocks	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q45, Q46, Q47	Tomo 01 · C.41 (Pág. 86)
1.01.2.004	Shock Cardiogénico & Diagnóstico Diferencial de los 4 Shocks	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q46, Q47, Q48	Tomo 01 · 2.5 (Pág. 36)
1.01.2.005	Shock Cardiogénico & Diagnóstico Diferencial de los 4 Shocks	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q46, Q47, Q49	Tomo 01 · 3.3 (Pág. 51)
1.01.2.007	Edema Agudo de Pulmón & Cuadrícula de Forrester	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q43, Q44	Tomo 01 · 3.4 (Pág. 55)
BLOQUE 4: VALVULOPATÍAS & SEMIOLOGÍA CARDIOVASCULAR					
1.01.1.002	Estenosis Aórtica: Semiología, Severidad & TAVI vs SAVR (Guía GES)	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q55, Q56	Tomo 01 · 1.8 (Pág. 19)
1.01.1.003	Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q57, Q58, Q59, Q60, Q61, Q62, Q63, Q64	Tomo 01 · 4.6 (Pág. 78)
1.01.1.004	Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q63, Q64, Q65	Tomo 01 · Cardiología (Pág. 8)
1.01.1.005	Insuficiencia Mitral Orgánica/Funcional & Prolapso Valvular Mitral (Barlow)	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q67, Q68, Q69	Tomo 01 · Cardiología (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.01.1.010	Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q66	Tomo 01 · 4.4 (Pág. 72)
1.01.1.011	Semiología de Soplos, Maniobras Dinámicas & Cardiopatías Congénitas del Adulto	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q70, Q71, Q72	Tomo 01 · 1.9 (Pág. 21)
1.01.1.012	Semiología de Soplos, Maniobras Dinámicas & Cardiopatías Congénitas del Adulto	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q71, Q72	Tomo 01 · 1.4 (Pág. 11)
1.01.1.013	Semiología de Soplos, Maniobras Dinámicas & Cardiopatías Congénitas del Adulto	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q71, Q72	Tomo 01 · 1.4 (Pág. 11)
BLOQUE 5: HTA, PATOLOGÍA VASCULAR & PERICARDIO					
1.01.1.014	Hipertensión Arterial Esencial & Secundaria: Diagnóstico, Metas GES & Terapia Dual	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q73, Q74	Tomo 01 · 1.4 (Pág. 11)
1.01.1.015	Hipertensión Arterial Esencial & Secundaria: Diagnóstico, Metas GES & Terapia Dual	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79	Tomo 01 · 5.1 (Pág. 87)
1.01.1.021	Pericarditis Aguda & Taponamiento Cardíaco	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q82, Q83, Q84	Tomo 01 · 4.1 (Pág. 66)
1.01.1.022	Pericarditis Aguda & Taponamiento Cardíaco	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q83, Q84, Q85	Tomo 01 · 5.5 (Pág. 97)
1.01.1.023	Patología de la Aorta: Disección Aórtica Aguda & Aneurisma de Aorta Abdominal	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q86, Q87, Q88	Tomo 06 · 5.6 (Pág. 81)
1.01.1.024	Patología de la Aorta: Disección Aórtica Aguda & Aneurisma de Aorta Abdominal	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q87, Q88	Tomo 01 · 1.6 (Pág. 15)
1.01.1.026	Tromboembolismo Pulmonar (TEP) & Trombosis Venosa Profunda (TVP)	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q89, Q90	Tomo 01 · Cardiología (Pág. 8)
1.01.2.006	Crisis Hipertensivas: Urgencia vs Emergencia Hipertensiva	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q80, Q81	Tomo 01 · 1.2 (Pág. 7)
1.01.2.008	Tromboembolismo Pulmonar (TEP) & Trombosis Venosa Profunda (TVP)	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q89, Q90	Tomo 01 · 5.6 (Pág. 99)

ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Cardiología · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.01.1.001	Angina Crónica Estable & Estratificación de Riesgo Funcional	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q19, Q20, Q21, Q22, Q23, Q24, Q25	Tomo 01 · 2.2 (Pág. 30)
1.01.1.002	Bradicardias Sintomáticas & Bloqueos AV (GES Marcapasos)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q15, Q16, Q17, Q55, Q56	Tomo 01 · 1.8 (Pág. 19)
1.01.1.003	Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q57, Q58, Q59, Q60, Q61, Q62, Q63, Q64	Tomo 01 · 4.6 (Pág. 78)
1.01.1.004	Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q63, Q64, Q65	Tomo 01 · Cardiología (Pág. 8)
1.01.1.005	Insuficiencia Mitral Orgánica/Funcional & Prolapso Valvular Mitral (Barlow)	Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q67, Q68, Q69	Tomo 01 · Cardiología (Pág. 8)
1.01.1.006	Insuficiencia Cardíaca Crónica: Fenotipos, Diagnóstico & Criterios Framingham	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q37, Q38, Q39, Q41, Q42	Tomo 01 · 5.9 (Pág. 105)
1.01.1.007	Insuficiencia Cardíaca Crónica: Fenotipos, Diagnóstico & Criterios Framingham	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q38, Q39, Q40, Q41, Q42	Tomo 01 · 4.7 (Pág. 80)
1.01.1.008	Complicaciones Mecánicas del IAM & Angina de Prinzmetal	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q33, Q34, Q35	Tomo 01 · 4.4 (Pág. 72)
1.01.1.009	Complicaciones Mecánicas del IAM & Angina de Prinzmetal	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q34, Q35, Q36	Tomo 01 · 4.2 (Pág. 68)
1.01.1.010	Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q66	Tomo 01 · 4.4 (Pág. 72)
1.01.1.011	Semiología de Soplos, Maniobras Dinámicas & Cardiopatías Congénitas del Adulto	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q70, Q71, Q72	Tomo 01 · 1.9 (Pág. 21)
1.01.1.012	Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q6, Q7, Q8, Q71, Q72	Tomo 01 · 1.4 (Pág. 11)
1.01.1.013	Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q7, Q8, Q9, Q71, Q72	Tomo 01 · 1.4 (Pág. 11)
1.01.1.014	Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q7, Q8, Q10, Q73, Q74	Tomo 01 · 1.4 (Pág. 11)
1.01.1.015	Hipertensión Arterial Esencial & Secundaria: Diagnóstico, Metas GES & Terapia Dual	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79	Tomo 01 · 5.1 (Pág. 87)
1.01.1.016	Miocardiopatías (Hipertrófica, Dilatada, Restrictiva & Miocarditis)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q50, Q51	Tomo 01 · 5.3 (Pág. 93)
1.01.1.017	Miocardiopatías (Hipertrófica, Dilatada, Restrictiva & Miocarditis)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q51, Q52	Tomo 01 · 4.3 (Pág. 70)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.01.1.018	Miocardiopatías (Hipertrófica, Dilatada, Restrictiva & Miocarditis)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q51, Q53	Tomo 01 · 3.1 (Pág. 45)
1.01.1.019	Miocardiopatías (Hipertrófica, Dilatada, Restrictiva & Miocarditis)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q51, Q54	Tomo 01 · 4.5 (Pág. 76)
1.01.1.020	SCASEST: Angina Inestable e IAM sin Supradesnivel del ST	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q26, Q27, Q28	Tomo 01 · 3.5 (Pág. 57)
1.01.1.021	Pericarditis Aguda & Taponamiento Cardíaco	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q82, Q83, Q84	Tomo 01 · 4.1 (Pág. 66)
1.01.1.022	Pericarditis Aguda & Taponamiento Cardíaco	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q83, Q84, Q85	Tomo 01 · 5.5 (Pág. 97)
1.01.1.023	Patología de la Aorta: Disección Aórtica Aguda & Aneurisma de Aorta Abdominal	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q86, Q87, Q88	Tomo 06 · 5.6 (Pág. 81)
1.01.1.024	TPSV & Síndrome de Wolff-Parkinson-White	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q11, Q12, Q13, Q87, Q88	Tomo 01 · 1.6 (Pág. 15)
1.01.1.025	Complicaciones Mecánicas del IAM & Angina de Prinzmetal	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q34, Q35	Tomo 01 · Cardiología (Pág. 8)
1.01.1.026	Tromboembolismo Pulmonar (TEP) & Trombosis Venosa Profunda (TVP)	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q89, Q90	Tomo 01 · Cardiología (Pág. 8)
1.01.2.001	SCASEST: Angina Inestable e IAM sin Supradesnivel del ST	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q27, Q28, Q29	Tomo 01 · 2.4 (Pág. 34)
1.01.2.002	SCACEST: IAM con Supradesnivel del ST & Protocolo Reperfusión GES	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q30, Q31, Q32	Tomo 01 · 5.7 (Pág. 101)
1.01.2.003	Shock Cardiogénico & Diagnóstico Diferencial de los 4 Shocks	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q45, Q46, Q47	Tomo 01 · C.41 (Pág. 86)
1.01.2.004	Shock Cardiogénico & Diagnóstico Diferencial de los 4 Shocks	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q46, Q47, Q48	Tomo 01 · 2.5 (Pág. 36)
1.01.2.005	Shock Cardiogénico & Diagnóstico Diferencial de los 4 Shocks	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q46, Q47, Q49	Tomo 01 · 3.3 (Pág. 51)
1.01.2.006	Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q3, Q4, Q5, Q80, Q81	Tomo 01 · 1.2 (Pág. 7)
1.01.2.007	Edema Agudo de Pulmón & Cuadrícula de Forrester	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q43, Q44	Tomo 01 · 3.4 (Pág. 55)
1.01.2.008	TPSV & Síndrome de Wolff-Parkinson-White	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q12, Q13, Q14, Q89, Q90	Tomo 01 · 5.6 (Pág. 99)
1.01.2.009	Bradicardias Sintomáticas & Bloqueos AV (GES Marcapasos)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q16, Q17, Q18	Tomo 01 · 1.7 (Pág. 17)
1.01.3.001	Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q7, Q8	Tomo 06 · 5.6 (Pág. 81)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.01.3.002	Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q4, Q5	Tomo 19 · 19.21 (Pág. 32)
1.01.3.003	SCACEST: IAM con Supradesnivel del ST & Protocolo Reperfusión GES	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q31, Q32	Tomo 01 · 1.5 (Pág. 13)
1.01.3.004	Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	GES	Q4, Q5	Tomo 06 · 5.6 (Pág. 81)
1.01.4.001	Lectura Sistemática del ECG en Urgencias y APS	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q1, Q2	Tomo 01 · 2.2 (Pág. 30)

SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

BLOQUE 1 ARRITMIAS, CONDUCCIÓN & URGENCIAS ELÉCTRICAS

PREGUNTA 1 — 1.01.4.001

1. Hombre de 52 años en tratamiento con claritromicina por neumonía presenta palpitaciones y mareos. El ECG revela ritmo sinusal a 75 lpm, intervalo QT medido de 520 ms y RR de 800 ms (QTc calculado de 581 ms mediante fórmula de Bazett). ¿Cuál es la conducta médica inmediata más adecuada?

A) Suspender de inmediato la claritromicina, monitorizar al paciente y corregir eventuales trastornos hidroelectrolíticos
B) Iniciar Amiodarona endovenosa para prevenir taquiarritmias
C) Indicar cardioversión eléctrica sincronizada
D) Administrar sulfato de atropina 1 mg endovenoso
E) Tranquilizar al paciente e indicar control ambulatorio en 1 semana

PREGUNTA 2 — 1.01.4.001

2. ¿Cuál de los siguientes hallazgos electrocardiográficos descarta la presencia de un ritmo sinusal normal?

A) Onda P negativa en la derivación DII y positiva en la derivación aVR
B) Frecuencia cardíaca de 65 latidos por minuto
C) Intervalo PR constante de 160 milisegundos
D) Onda P positiva en DI y aVF
E) Complejo QRS precedido por una onda P con intervalo R-R regular

PREGUNTA 3 — 1.01.2.006

3. Diabético hipertenso con dolor torácico súbito, luego compromiso de conciencia y ausencia de pulso. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Desfibrilación inmediata sin RCP previa
B) Iniciar compresiones torácicas externas (RCP)
C) Intubación orotraqueal inmediata
D) Administrar adrenalina 1 mg EV de inmediato
E) Acceso venoso y carga de volumen

PREGUNTA 4 — 1.01.2.006, 1.01.3.002, 1.01.3.004

4. Durante la reanimación cardiopulmonar avanzada de una mujer de 50 años en fibrilación ventricular, se realiza la primera descarga de 200 J bifásicos. ¿Cuál es la acción inmediata que debe realizar el equipo?

A) Reanudar inmediatamente las compresiones torácicas durante 2 minutos antes de cualquier otra evaluación
B) Palpar el pulso carotídeo para verificar si recuperó circulación espontánea
C) Mirar el monitor para comprobar si el ritmo cambió a sinusal
D) Administrar inmediatamente 1 mg de adrenalina endovenosa
E) Administrar 300 mg de amiodarona en bolo rápido

PREGUNTA 5 — 1.01.2.006, 1.01.3.002, 1.01.3.004

5. Hombre de 70 años hospitalizado entra en paro cardiorrespiratorio. El monitor muestra una línea isoeléctrica plana en dos derivaciones con electrodos bien posicionados. ¿Cuál de las siguientes intervenciones está CONTRAINDICADA?

A) Aplicar una descarga eléctrica de 200 J
B) Administrar Adrenalina 1 mg endovenosa
C) Realizar compresiones torácicas continuas a 100-120 por minuto
D) Ventilar con bolsa-mascarilla conectada a oxígeno
E) Buscar causas reversibles de asistolia

PREGUNTA 6 — 1.01.1.012

6. Paciente de 70 años, con antecedente de EPOC tabáquico, presenta cuadro de 3 meses de aumento de su disnea basal asociado a palpitaciones. Al examen físico destaca frecuencia cardiaca de 100 por minuto, ritmo cardiaco irregular con ausencia de soplos y murmullo pulmonar presente con roncus y sibilancias difusas. Se realiza electrocardiograma que muestra ausencia de onda "p", de forma irregular y presencia de QRS angosto. ¿Cuál de los siguientes fármacos estará contraindicado para el manejo de este paciente?

A) Verapamilo
B) Lanantósido C
C) Losartán
D) Amiodarona
E) Carvedilol

PREGUNTA 7 — 1.01.1.012, 1.01.1.013, 1.01.1.014, 1.01.3.001

7. Mujer de 76 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 acude a control en APS. Se encuentra asintomática. Al examen: pulso irregular a 84 lpm. ECG confirma fibrilación auricular crónica no valvular. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada respecto a la prevención de eventos tromboembólicos?

A) Iniciar anticoagulación oral permanente con un anticoagulante oral directo (DOAC)
B) Indicar Aspirina 100 mg al día en monoterapia
C) Indicar terapia combinada de Aspirina más Clopidogrel
D) No indicar anticoagulación por encontrarse en frecuencia cardíaca controlada
E) Realizar cardioversión eléctrica ambulatoria inmediata

PREGUNTA 8 1.01.1.012, 1.01.1.013, 1.01.1.014, 1.01.3.001

8. Hombre de 60 años portador de una prótesis valvular mecánica mitral consulta por fibrilación auricular. ¿Cuál es el tratamiento anticoagulante de elección?

A) Acenocumarol o Warfarina con meta de INR entre 2.5 y 3.5
B) Apixabán 5 mg cada 12 horas
C) Rivaroxabán 20 mg al día
D) Dabigatrán 150 mg cada 12 horas
E) Heparina de bajo peso molecular por vía subcutánea indefinida

PREGUNTA 9 1.01.1.013

9. Paciente con ECG que muestra fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida (130 lpm) y función ventricular conservada. Hemodinámicamente estable. ¿Cuál es el fármaco de elección para control de frecuencia?

A) Metoprolol oral
B) Amiodarona EV
C) Digoxina EV
D) Flecainida oral
E) Sotalol oral

PREGUNTA 10 1.01.1.014

10. Un paciente de 71 años, con antecedente de reemplazo valvular tricuspídeo, secundario a una endocarditis bacteriana, con prótesis biológica in situ consulta por consulta por palpitaciones muy intensas, asociadas a disnea. Al examen físico tiene un pulso a 140 latidos por minutos, regular. Se realizan maniobras vagales (masaje carotídeo) y se observa el siguiente electrocardiograma (fuente: slideshare): El diagnóstico más probable es:

A) Taquicardia paroxística supraventricular
B) Fibrilación auricular
C) Flutter auricular
D) Síndrome de Wolff Parkinson White
E) Taquicardia auricular

PREGUNTA 11 1.01.1.024

11. Un paciente de 28 años consulta por dolor torácico y disnea de 2 horas de evolución. Al examen Fsico presenta taquicardia a 170 lpm, presión arterial 120/80 mmHg y un examen cardiopulmonar con ritmo regular en dos tonos, sin soplos, en la auscultación cardíaca y murmullo pulmonar presente, sin ruidos agregados, en la auscultación pulmonar. Se solicita un electrocardiograma que se muestra a con8nuación: ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Verapamilo endovenoso
B) Amiodarona endovenosa
C) Adrenalina endovenosa
D) Adenosina endovenosa
E) Cardioversión eléctrica

PREGUNTA 12 1.01.1.024, 1.01.2.008

12. Hombre de 26 años con palpitaciones paroxísticas regulares de inicio súbito a 180 lpm y QRS estrecho. Se realizaron maniobras vagales sin éxito. ¿Cuál es el fármaco de primera línea y la técnica correcta de administración?

A) Adenosina 6 mg en bolo endovenoso ultrarrápido seguido de bolo de 20 mL de suero fisiológico
B) Amiodarona 300 mg en infusión continua para 1 hora
C) Verapamilo 10 mg por vía intramuscular profunda
D) Digoxina 0.5 mg en infusión lenta
E) Lidocaína 100 mg endovenosa

PREGUNTA 13 1.01.1.024, 1.01.2.008

13. ¿Cuál de los siguientes fármacos antiarrítmicos puede desencadenar fibrilación ventricular y paro cardíaco si se administra a un paciente con fibrilación auricular preexcitada (Wolff-Parkinson-White)?

A) Verapamilo
B) Procainamida
C) Ibutilide
D) Sulfato de Magnesio
E) Quinidina

PREGUNTA 14 1.01.2.008

14. Clínica de taponamiento, hipotensión, pulsos disminuidos como realizo el diagnóstico:

A) Ecocardiograma
B) Hemograma y VHS
C) Ecografía
D) Radiografía
E) TAC con contraste

PREGUNTA 15 1.01.1.002

15. Un paciente de 62 años presenta malestar general marcado, desde hace 20 minutos. Al examen físico está sudoroso, tiene FC: 33x', PA: 120/50 mmHg. Se solicita un electrocardiograma que se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:

A) Bloqueo auriculoventricular de primer grado
B) Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo I
C) Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo II
D) Bloqueo auriculoventricular de tercer grado
E) Enfermedad del nodo sinusal

PREGUNTA 16 1.01.1.002, 1.01.2.009

16. Hombre de 76 años consulta por astenia y mareos de 3 días. El ECG revela ondas P a 70 lpm e intervalos PR de 160 ms constantes, pero cada tres ondas P, una no es seguida de complejo QRS sin que haya existido alargamiento previo del PR. El complejo QRS mide 130 ms. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta definitiva?

A) Bloqueo AV de 2° grado Mobitz II; requiere implante de marcapaso definitivo
B) Bloqueo AV de 2° grado Mobitz I; requiere observación ambulatoria
C) Bloqueo AV de 1er grado; requiere suspender fármacos cronótropos
D) Disociación auriculoventricular por intoxicación digitálica
E) Paro sinusal con ritmo de escape de la unión

PREGUNTA 17 1.01.1.002, 1.01.2.009

17. Paciente de 85 años ingresa a SAPU en shock cardiogénico con FC de 28 lpm por BAV de tercer grado. Se administra Atropina 1 mg EV sin respuesta de la frecuencia cardíaca ni de la presión arterial. ¿Cuál es el paso inmediato que debe realizar el médico tratante?

A) Instalar marcapaso externo transcutáneo e iniciar infusión de Adrenalina
B) Repetir Atropina hasta completar 6 mg
C) Administrar Amiodarona 300 mg endovenosa
D) Realizar cardioversión eléctrica sincronizada a 100 J
E) Derivar en ambulancia básica sin monitor

PREGUNTA 18 1.01.2.009

18. Un paciente ingresa al servicio de urgencia, por un cuadro de disnea marcada y síncopes. Al examen físico está confuso, con pulso de 200 latidos por minuto, regular y presión arterial de 70/40 mmHg. Además, tiene frialdad de extremidades y piel sudorosa. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado en este momento?

A) Maniobras vagales
B) Amiodarona endovenosa
C) Adenosina endovenosa
D) Desfibrilación
E) Cardioversión eléctrica

BLOQUE 2 CARDIOPATÍA CORONARIA & SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS

PREGUNTA 19 1.01.1.001

19. Un paciente con antecedente de hipertensión arterial, dislipidemia y diabetes, usuario de aspirina, metformina, hidroclorotiazida y atorvastatina, presenta dolor torácico opresivo, que aparece al caminar 2 cuadras y alcanza un EVA de 5/10. Se solicita un test de esfuerzo que demuestra aparición de un infradesnivel del segmento ST, de 2 mm en las derivadas anteriores. El examen más adecuado para proseguir el estudio es:

A) Ecocardiograma
B) TAC de tórax
C) Ecocardiografía de esfuerzo
D) Coronariografía
E) Cintigrafía de perfesión miocárdica

PREGUNTA 20 1.01.1.001

20. Hombre de 63 años con hipertensión y diabetes tipo 2 consulta por dolor torácico opresivo de 1 mes de evolución que aparece al subir dos pisos por escalera y desaparece a los 3 minutos de reposo. El ECG basal es normal. ¿Cuál es la prueba diagnóstica no invasiva de primera línea más adecuada para confirmar isquemia miocárdica y evaluar pronóstico en APS?

A) Test de esfuerzo convencional en cinta rodante (Ergometría)
B) Coronariografía invasiva inmediata sin pruebas previas
C) Radiografía de tórax póstero-anterior y lateral
D) Determinación seriada de troponinas en reposo
E) Holter de ritmo cardíaco de 24 horas

PREGUNTA 21 1.01.1.001

21. ¿Cuál de los siguientes fármacos ha demostrado reducir de forma categórica la mortalidad a largo plazo y la tasa de infarto agudo al miocardio en pacientes portadores de angina crónica estable?

A) Atorvastatina en dosis de alta potencia (80 mg al día)
B) Nitroglicerina sublingual en esquema fijo tres veces al día
C) Diltiazem oral en monoterapia
D) Mononitrato de Isosorbida 20 mg cada 12 horas
E) Trimetazidina 35 mg cada 12 horas

PREGUNTA 22 1.01.1.001

22. Paciente de 58 años, con antecedente de diabetes mellitus, hipertensión y fumador de 40 paquetes año, consulta por un cuadro de tres semanas de evolución de dolor epi- gástrico opresivo, asociado a disnea y palpitaciones regulares, que lo obligan a detener- se cada 100 metros de caminata y ceden con el reposo. En el examen físico, su presión arterial es 140/90 mmHg, frecuencia cardiaca de 80 latidos por minuto regular. El diag-

A) Angina crónica de reciente comienzo
B) Fibrilación auricular paroxística
C) Isquemia cardiaca con arritmia supraventricular
D) Tromboembolismo pulmonar
E) Cardiopatía hipertensiva

PREGUNTA 23 1.01.1.001

23. Un paciente de 55 años, con antecedentes de diabetes mellitus 8po 2, hipertensión arterial y tabaquismo de 20 paquetes-año, consulta por dolor torácico de localización precordial y carácter opresivo. El cuadro inició hace tres semanas, presentándose el dolor en relación con la ac8vidad Fsica y desapareciendo rápidamente con el reposo. Sus signos vitales muestran presión arterial 148/92 mmHg, frecuencia cardíaca 81 la8dos por minuto y saturación arterial de oxígeno de 96%. Su examen cardiopulmonar no muestra alteraciones. ¿Cuál es el examen de elección para precisar el diagnós8co?

A) Coronariogra:a
B) Cin2gra:a miocárdica
C) Angiorresonancia de arterias coronarias
D) Test de esfuerzo
E) Electrocardiograma de 24 horas (Holter)

PREGUNTA 24 1.01.1.001

24. Un paciente de 68 años, fumador y dislipidémico, en tratamiento con lavastatina y aspirina, comienza hace 2 meses con angina de pecho persistente, pero estable. ¿Qué fármaco es recomendable agregar?

A) Amlodipino
B) Dinitrato de isosorbide
C) Carvedilol
D) Enalapril
E) Hidroclorotiazida

PREGUNTA 25 1.01.1.001

25. Un paciente de 65 años, hipertenso y diabético, consulta por disnea y dolor de precordial, que aparece en relación al ejercicio. Es usuario de aspirina, enalapril, metformina, glibenclamida y atorvastatina. Refiere que le es imposible subir más de dos pisos en su edificio o caminar más de dos cuadras sin detenerse, debido al dolor. Su examen físico es normal, al igual que su electrocardiograma. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Derivar a unidad de salud mental
B) Solicitar test de esfuerzo
C) Solicitar troponinas
D) Indicar programa de ejercicios supervisados, con aumento progresivo
E) Iniciar anticoagulación oral Nota: pregunta añadida a la reconstrucción.

PREGUNTA 26 1.01.1.020

26. Un paciente de 40 años consulta por un síncope, mientras jugaba fútbol, con recuperación completa. Además refiere disnea de esfuerzos que inició hace 3 meses y que ha aumentado lentamente. Su hermano murió súbitamente a los 25 años. Al examen físico se constata un soplo sistólico eyectivo, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

A) Tromboembolismo pulmonar
B) Síndrome de Brugada
C) Miocardiopatía hipertrófica
D) Síncome disautonómico
E) Síndrome de QT largo

PREGUNTA 27 1.01.1.020, 1.01.2.001

27. Hombre de 64 años con dolor torácico opresivo de reposo prolongado ingresa a urgencias. El ECG muestra infradesnivel del ST de 2 mm en derivaciones DII, DIII y aVF. Troponinas ultrasensibles positivas. ¿Cuál es el esquema antitrombótico inicial más adecuado mientras se programa la coronariografía?

A) Aspirina 250 mg + Ticagrelor 180 mg + Enoxaparina 1 mg/kg subcutánea
B) Aspirina 100 mg en monoterapia oral
C) Trombólisis con Tenecteplase endovenoso inmediato
D) Heparina no fraccionada en infusión sin antiagregantes plaquetarios
E) Acenocumarol oral para alcanzar INR de 2.5

PREGUNTA 28 1.01.1.020, 1.01.2.001

28. ¿Cuál de los siguientes pacientes con SCASEST tiene indicación de coronariografía invasiva urgente en MENOS de 2 horas?

A) Paciente con dolor torácico persistente refractario al tratamiento médico e inestabilidad hemodinámica
B) Paciente de 60 años asintomático tras recibir nitroglicerina con TIMI de 2 puntos
C) Paciente con dolor torácico autolimitado y troponinas negativas
D) Paciente hipertenso con ECG normal y dolor atípico
E) Paciente con Score GRACE de 110 puntos sin nuevos episodios de dolor

PREGUNTA 29 1.01.2.001

29. Síndrome adrenérgico por cocaína. Fármaco contraindicado.

A) Atenolol
B) Captopril
C) Nitroglicerina
D) Diltiazem
E) Amoxicilina

PREGUNTA 30 1.01.2.002

30. Un paciente de 69 años, con antecedente de hipertensión y diabetes, consulta por dolor torácico intenso EVA 10/10, de carácter lancinante y que se irradia a cuello y dorso. A lo anterior se agregó dolor intenso en la extremidad superior izquierda. Al examen físico tiene FC: 120x', PA: 200/140 mmHg, ritmo regular en dos tiempos, sin soplos, murmullo pulmonar bilateral conservado, sin otros ruidos, extremidad superior izquierda con disminución del pulso radial y frialdad de la mano. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Pericarditis aguda
B) Disección aórtica
C) Tromboembolismo pulmonar
D) Infarto agudo al miocardio
E) Embolias cardíacas

PREGUNTA 31 1.01.2.002, 1.01.3.003

31. Hombre de 60 años consulta en hospital comunal sin hemodinamia por dolor precordial típico de 40 minutos de evolución. ECG revela supradesnivel del ST de 4 mm de V1 a V4. El centro terciario con capacidad de angioplastía está a 150 minutos de traslado. ¿Cuál es la conducta médica de elección?

A) Administrar Tenecteplase endovenoso en bolo inmediatamente en el hospital comunal
B) Derivar en ambulancia básica a angioplastía primaria sin trombolisis previa
C) Administrar heparina en infusión y esperar resultado de troponinas
D) Realizar test de esfuerzo para confirmar extensión del infarto
E) Indicar nitroglicerina sublingual y reposo absoluto sin fármacos trombolíticos

PREGUNTA 32 1.01.2.002, 1.01.3.003

32. Paciente con infarto agudo al miocardio de pared inferior evoluciona con PA 80/40 mmHg, ingurgitación yugular y examen pulmonar sin ruidos agregados. El ECG muestra supradesnivel del ST de 2 mm en V4R. ¿Cuál es el tratamiento inicial más apropiado para su hipotensión?

A) Administración rápida de carga de suero fisiológico endovenoso
B) Infusión continua de nitroglicerina
C) Administración de Furosemida 40 mg endovenosa
D) Administración de Morfina 5 mg endovenosa
E) Inicio inmediato de Propanolol oral

PREGUNTA 33 1.01.1.008

33. Hombre de 62 años en su 5° día post-infarto agudo al miocardio evoluciona con hipotensión severa y disnea. Al examen destaca un soplo pansistólico rudo con frémito en el borde esternal izquierdo bajo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Rotura del tabique interventricular (CIV post-IAM)
B) Rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo
C) Insuficiencia aórtica aguda
D) Reinfarto miocárdico con pericarditis
E) Tromboembolismo pulmonar masivo

PREGUNTA 34 1.01.1.008, 1.01.1.009, 1.01.1.025

34. Hombre de 62 años en su 5° día post-infarto agudo al miocardio evoluciona con hipotensión severa y disnea. Al examen destaca un soplo pansistólico rudo con frémito en el borde esternal izquierdo bajo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Rotura del tabique interventricular (CIV post-IAM)
B) Rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo
C) Insuficiencia aórtica aguda
D) Reinfarto miocárdico con pericarditis
E) Tromboembolismo pulmonar masivo

PREGUNTA 35 1.01.1.008, 1.01.1.009, 1.01.1.025

35. Mujer de 35 años fumadora consulta por dolor torácico opresivo nocturno en reposo. El ECG durante el dolor muestra supradesnivel del ST de 2 mm en derivaciones anteriores que se normaliza completamente al ceder el dolor con nitroglicerina sublingual. La coronariografía no muestra lesiones obstructivas fijas. ¿Cuál es el fármaco profiláctico de primera línea?

A) Amlodipino o Diltiazem
B) Propranolol oral
C) Atenolol oral
D) Carvedilol oral
E) Metoprolol succinato

PREGUNTA 36 1.01.1.009

36. Un paciente de 80 años presenta disnea de esfuerzo de algunos meses de evolución, progresiva. Hace 24 horas sufre un síncope, con recuperación completa. Al examen físico tiene FC: 75x', PA: 110/70 mmHg se palpa el choque de la punta en el 4° espacio intercostal, línea medio clavicular y se ausculta el corazón con presencia de soplo protomesosistólico III/VI y segundo ruido muy apagado. El examen pulmonar no muestra alteraciones. Se solicita un electrocardiograma, que muestra un ritmo sinusal con onda S de 23 mm en V2 y onda R de 16 mm en V5. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Estenosis aórtica
B) Estenosis mitral
C) Insuficiencia aórtica
D) Insuficiencia mitral
E) Cardiopatía coronaria

BLOQUE 3 INSUFICIENCIA CARDÍACA, MIOCARDIOPATÍAS & SHOCK

PREGUNTA 37 1.01.1.006

37. Hombre de 68 años con hipertensión arterial de 20 años de evolución consulta por disnea de esfuerzos progresiva y ortopnea de 2 semanas. Al examen físico destaca ingurgitación yugular, ritmo de galope con tercer ruido auscultable en el ápex y crépitos basales bilaterales. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable según los criterios de Framingham?

A) Insuficiencia cardíaca congestiva descompensada
B) Crisis de asma bronquial del adulto
C) Tromboembolismo pulmonar crónico
D) Neumonía bacteriana multilobar
E) Estenosis traqueal extrínseca

PREGUNTA 38 1.01.1.006, 1.01.1.007

38. Hombre de 68 años con hipertensión arterial de 20 años de evolución consulta por disnea de esfuerzos progresiva y ortopnea de 2 semanas. Al examen físico destaca ingurgitación yugular, ritmo de galope con tercer ruido auscultable en el ápex y crépitos basales bilaterales. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable según los criterios de Framingham?

A) Insuficiencia cardíaca congestiva descompensada
B) Crisis de asma bronquial del adulto
C) Tromboembolismo pulmonar crónico
D) Neumonía bacteriana multilobar
E) Estenosis traqueal extrínseca

PREGUNTA 39 1.01.1.006, 1.01.1.007

39. En un paciente de 75 años que consulta en el servicio de urgencia por disnea súbita, ¿cuál de los siguientes exámenes de laboratorio posee el mayor valor predictivo negativo para descartar origen cardiogénico?

A) Péptido natriurético tipo B (BNP o NT-proBNP)
B) Troponina ultrasensible en muestra única
C) Dímero D plasmático
D) Gases arteriales basales
E) Proteína C Reactiva ultrasensible

PREGUNTA 40 1.01.1.007

40. Un paciente de 45 años, consulta por fiebre de 3 semanas de evolución sin otros sín- tomas. Al examen físico tiene temeratura 37,8°C, frecuencia cardiaca de 92 por minuto, con presión arterial 120/80mmHG. Al examen cardiaco se ausulta un soplo sistólico en ápex irradiado a dorso. En sus exámenes destacan leucocitos de 12.000/mm3 y PCR 9,6 (valor normal menor a 1,0). ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio?

A) Ecocardiografía bidimensional
B) Resonancia magnética cardiaca
C) Radiografía de tórax
D) AngioTAC de tórax
E) TAC de tórax abdomen y pelvis

PREGUNTA 41 1.01.1.006, 1.01.1.007

41. Hombre de 62 años con IC-FEr (FEVI 32%) en tratamiento con Enalapril 20 mg/día y Carvedilol 25 mg c/12h. El médico decide cambiar el IECA por Sacubitrilo/Valsartán. ¿Cuál es la indicación farmacológica crítica que debe darse al paciente?

A) Suspender el Enalapril y esperar al menos 36 horas antes de tomar la primera dosis de Sacubitrilo/Valsartán
B) Tomar ambos fármacos simultáneamente durante la primera semana
C) Suspender el Carvedilol de forma permanente
D) Asociar Espironolactona en dosis de 100 mg antes de hacer el cambio
E) Realizar el cambio directo sin ningún período de espera

PREGUNTA 42 1.01.1.006, 1.01.1.007

42. ¿Cuál de los siguientes fármacos para la insuficiencia cardíaca alivia rápidamente los síntomas congestivos pero NO ha demostrado reducir la mortalidad a largo plazo en pacientes con IC-FEr?

A) Furosemida
B) Empagliflozina
C) Carvedilol
D) Espironolactona
E) Sacubitrilo / Valsartán

PREGUNTA 43 1.01.2.007

43. Hombre de 70 años con edema agudo de pulmón hipertensivo (PA 200/110 mmHg, $SatO_2$ 82%). ¿Cuál es la terapia respiratoria no farmacológica de primera línea más efectiva para evitar la intubación orotraqueal?

A) Ventilación no invasiva con presión positiva continua (CPAP)
B) Oxigenoterapia por cánula nasal a 2 litros por minuto
C) Intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva inmediata
D) Nebulización continua con Salbutamol
E) Aspiración traqueal a circuito abierto

PREGUNTA 44 1.01.2.007

44. ¿Cuál es el vasodilatador endovenoso de elección para el manejo agudo de un paciente con edema pulmonar cardiogénico con presión arterial de 190/100 mmHg?

A) Nitroglicerina en infusión continua endovenosa
B) Nifedipino sublingual en cápsula
C) Nitroprusiato de sodio asociado a betabloqueadores
D) Hidralazina intramuscular
E) Atenolol endovenoso en bolo

PREGUNTA 45 1.01.2.003

45. Hombre de 58 años en shock cardiogénico refractario a volumen tras infarto agudo al miocardio. Presenta PA 75/45 mmHg y signos de hipoperfusión. ¿Cuál es el vasopresor de primera línea recomendado para restaurar la presión arterial media?

A) Noradrenalina en infusión continua
B) Dopamina en dosis altas
C) Fenilefrina en bolo
D) Isoproterenol endovenoso
E) Epinefrina subcutánea

PREGUNTA 46 1.01.2.003, 1.01.2.004, 1.01.2.005

46. Hombre de 58 años en shock cardiogénico refractario a volumen tras infarto agudo al miocardio. Presenta PA 75/45 mmHg y signos de hipoperfusión. ¿Cuál es el vasopresor de primera línea recomendado para restaurar la presión arterial media?

A) Noradrenalina en infusión continua
B) Dopamina en dosis altas
C) Fenilefrina en bolo
D) Isoproterenol endovenoso
E) Epinefrina subcutánea

PREGUNTA 47 1.01.2.003, 1.01.2.004, 1.01.2.005

47. Un paciente en shock presenta mediante monitoreo hemodinámico: Gasto Cardíaco aumentado, Resistencia Vascular Sistémica disminuida y Presión Capilar Pulmonar baja. ¿Cuál es el tipo de shock?

A) Shock distributivo / séptico
B) Shock cardiogénico
C) Shock hipovolémico
D) Shock obstructivo por taponamiento
E) Shock obstructivo por TEP masivo

PREGUNTA 48 1.01.2.004

48. Un paciente de 62 años, con antecedentes de dislipidemia y diabetes en tratamiento con dieta e hipoglicemiantes orales, consulta por dolor toráxico opresivo irradiado a ambos hombros intenso EVA 9/10, asociado a disnea y sudoración. Al examen físico, su presión arterial es 140/70 mmHg con frecuencia cardiaca de 80 latidos por minuto. Pre- senta RR3T con presencia de R3, murmullo pulmonar presente con crépitos bibasales. Electrocardiagrama: SDST en V1-V4. La conducta más adecuada es:

A) Tratamiento anticoagulante
B) Tratamiento antiplaquetario
C) Solicitar AngioTAC de tórax
D) Ecocardiograma bidimensional
E) Coronariografía de urgencia

PREGUNTA 49 1.01.2.005

49. (88) Paciente de 82 años con historia de 2 semanas de disnea progresiva FC 92 lpm PA 200/100 SatO2 90%. Al examen físico ingurgitación yugular, ritmo regular en tres tiempos por R3 al examen pulmonar créditos bibasales. ECG: ritmo sinusal con signos de sobrecarga del VI. Diagnóstico más probable:

A) SCA
B) Disección aórtica
C) NAC
D) IC aguda
E) TEP f. Dolor torácico súbito, transfixiante, HTA y soplo diastólico.

PREGUNTA 50 1.01.1.016

50. **Paciente con HTA en tratamiento triple (enalapril, amlodipino e hidroclorotiazida) con presiones elevadas persistentes. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Aumentar dosis de enalapril al máximo
B) Agregar beta-bloqueador oral
C) Suspender hidroclorotiazida y agregar furosemida
D) Derivar a nefrología de urgencia
E) Agregar espironolactona e iniciar estudio de HTA secundaria

PREGUNTA 51 1.01.1.016, 1.01.1.017, 1.01.1.018, 1.01.1.019

51. **Atleta de 20 años asintomático es evaluado en control deportivo. Se ausculta un soplo sistólico eyectivo en borde esternal izquierdo que AUMENTA de intensidad al ponerse de pie e inclinarse y DISMINUYE al colocarse en cuclillas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
B) Estenosis aórtica degenerativa
C) Insuficiencia mitral reumática
D) Comunicación interauricular
E) Estenosis pulmonar congénita

PREGUNTA 52 1.01.1.017

52. **Pregunta 71 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Una paciente de 81 años consulta por disnea de esfuerzos, progresiva, asociada a paroxística nocturna y ortopnea. Al examen físico se objetiva PA: 160/60 mmHg, con pulso regular, amplio, a 72 lpm. Su examen cardíaco muestra desplazamiento del choque cardíaco, con presencia de un soplo intenso, entre el segundo y el primer ruido cardíaco, que se irradia al cuello. El examen pulmonar muestra crepitaciones escasas, en ambas bases. El diagnóstico de sospecha es:**

A) Insuficiencia tricuspídea
B) Estenosis aórtica
C) Insuficiencia aórtica
D) Estenosis mitral
E) Insuficiencia mitral

PREGUNTA 53 1.01.1.018

53. **Un paciente de 68 años con antecedentes de infarto de miocardio, hipertensión arterial y tabaquismo se encuentra en tratamiento con aspirina, atorvastatina, enalapril 20 mg cada 12 horas, carvedilol 12,5 mg al día, furosemida 40 mg cada 12 horas. Actualmente presenta disnea de pequeños esfuerzos. Al examen físico, tiene frecuencia cardíaca: 65x', presión arterial: 110/70 mmHg, saturación de oxígeno del 96%; en el examen cardiopulmonar se auscultan crépitos pulmonares bibasales y ritmo cardíaco regular en dos tiempos, con un soplo sistólico III/VI. El choque de la punta es palpable en la línea axilar media y presenta edema en los miembros inferiores. ¿Cuál de las siguientes medidas es la más adecuada para este paciente?**

A) Agregar losartán
B) Agregar hidralazina
C) Agregar isosorbide
D) Agregar espironolactona
E) Agregar amiodarona

PREGUNTA 54 1.01.1.019

54. **Una paciente de 45 años, con antecedente de enfermedad reumá8ca en la infancia, consulta por un cuadro de 3 meses de evolución de disnea de esfuerzos en capacidad funcional II, que actualmente ha progresado a disnea de mínimos esfuerzos. Al examen Fsico, su presión arterial es de 120/78 mmHg, su frecuencia cardíaca es de 92 la8dos por minuto y su saturación de oxígeno es de 93% a aire ambiental. Se ausculta un soplo holosistólico en el ápex, irradiado a la axila y se palpa el choque de la punta hiperdinámico a la altura del quinto espacio intercostal. El examen pulmonar muestra crepitaciones basales bilaterales. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

A) Insuficiencia mitral
B) Insuficiencia aór2ca
C) Estenosis mitral
D) Estenosis aór2ca
E) Ductus arterioso persistente

BLOQUE 4 VALVULOPATÍAS & SEMIOLOGÍA CARDIOVASCULAR

PREGUNTA 55 1.01.1.002

55. **Hombre de 76 años consulta por disnea de esfuerzos progresiva y mareos. Al examen físico destaca un pulso carotídeo de baja amplitud y ascenso lento (parvus et tardus) y un soplo mesosistólico en foco aórtico irradiado a carótidas. Ecocardiograma: área valvular aórtica de 0.8 cm² y gradiente medio de 45 mmHg con FEVI de 55%. ¿Cuál es la conducta médica definitiva más adecuada?**

A) Reemplazo valvular aórtico percutáneo (TAVI) o quirúrgico
B) Tratamiento médico exclusivo con Betabloqueadores y control anual
C) Iniciar Enalapril y Nitratos en dosis crecientes
D) Valvuloplastía aórtica con balón como tratamiento curativo definitivo
E) Test de esfuerzo convencional para medir capacidad funcional

PREGUNTA 56 1.01.1.002

56. **¿Cuál es la causa más frecuente de estenosis aórtica en un paciente de 45 años sin antecedentes de fiebre reumática?**

A) Válvula aórtica bicúspide congénita
B) Degeneración fibrocalcárea senil
C) Endocarditis infecciosa por enterococo
D) Aterosclerosis de la raíz aórtica
E) Lupus eritematoso sistémico (Libman-Sacks)

PREGUNTA 57 1.01.1.003

57. **Un paciente de 28 años, con antecedente de haber sido operado de coartación aórtica cuando niño, consulta por un cuadro progresivo de disnea de esfuerzos y ortopnea, que ha deteriorado significativamente su capacidad funcional. En el examen físico tiene pulso palpable con frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, presión arterial de 155/75 mmHg y frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto, saturando 92% a FiO2 ambiental. Al examen cardiopulmonar, tiene ritmo regular en dos tonos, con soplo sistólico eyectivo II/VI en la zona paraesternal, más un soplo diastólico, que se escucha hasta la final de la diástole en el mismo foco. Su padre falleció a los 50 años, de manera súbita. ¿Cuál es el diagnóstico más importante?**

A) Recoartación aórtica
B) Estenosis aórtica
C) Insuficiencia aórtica
D) Insuficiencia tricuspídea
E) Disección aórtica

PREGUNTA 58 1.01.1.003

58. **Mujer de 45 años que recuerda que durante un embarazo hace 20 años le diagnosticaron un soplo cardíaco. Actualmente asintomática, tolera el ejercicio normal. Auscultación: soplo sistólico II/VI en foco pulmonar con desdoblamiento fijo del segundo ruido. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Tetralogía de Fallot
B) Ductus arterioso persistente
C) Estenosis pulmonar
D) Comunicación interauricular (CIA)
E) Comunicación interventricular

PREGUNTA 59 1.01.1.003

59. **Un hombre de 40 años consulta por disnea de esfuerzos de algunos años de evolución, que aparece con medianos esfuerzos, asociada a palpitaciones ocasionales. Al examen físico tiene edema de extremidades inferiores, FC: 75x', PA: 120/80 mmHg, murmullo pulmonar presente, con escasos crépitos bibasales y al examen cardíaco presenta un soplo sistólico de ubicación paraesternal, con segundo ruido desdoblado fijo. Se solicita un electrocardiograma, que muestra eje a +120°, fibrilación auricular, con un bloqueo completo de la rama derecha del haz de His. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Comunicación interauricular
B) Ductus arteriosos persistente
C) Comunicación interventricular
D) Estenosis aórtica
E) Estenosis mitral

PREGUNTA 60 1.01.1.003

60. **Pregunta 32 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Una paciente de 40 años, consulta por un cuadro, de algunos meses de evolución, de disnea de esfuerzos, progresiva, asociada a ortopnea y edema de extremidades inferiores. Al examen físico se auscultan crepitaciones pulmonares bilaterales, con un soplo en la zona paraesternal izquierda, en el segundo espacio intercostal. Su radiografía muestra signos de hiperflujo pulmonar, con botón pulmonar prominente. Su electrocardiograma muestra un patrón rSr. El diagnóstico más probable es:**

A) Comunicación interauricular
B) Dustus arterioso persistente
C) Estenosis aórtica
D) Comunicación interventricular
E) Insuficiencia aórtica

PREGUNTA 61 1.01.1.003

61. **Un hombre de 40 años consulta por disnea y palpitaciones ocasionales. Al examen físico presenta un soplo sistólico basal, con desdoblamiento fijo del segundo ruido. Se solicita un electrocardiograma, que muestra un bloqueo completo de rama derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Comunicación interauricular
B) Ductus arteriosos persistente
C) Comunicación interventricular
D) Estenosis aórtica
E) Estenosis pulmonar

PREGUNTA 62 1.01.1.003

62. **Un paciente de 30 años presneta un cuadro de astenia, adinamia y disnea de esfuerzos. Presenta un soplo sistólico eyectivo, con desdoblamiento del segundo ruido y algunos crépitos pulmonares. Su electrocardiograma muestra un bloqueo completo de rama derecha. El diagnóstico más probable es:**

A) Comunicación interventricular
B) Comunicación interauricular
C) Ductus arterioso persistente
D) Tetralogía de Fallot
E) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva

PREGUNTA 63 1.01.1.003, 1.01.1.004

63. **Hombre de 48 años hipertenso con soplo cardíaco presenta al examen PA 170/45 mmHg, pulso de ascenso rápido y colapso súbito (pulso céler) y oscilación de la cabeza rítmica con el pulso (signo de Musset). ¿Cuál es la valvulopatía causante?**

A) Insuficiencia aórtica severa
B) Estenosis aórtica severa
C) Insuficiencia mitral severa
D) Estenosis pulmonar
E) Coartación aórtica

PREGUNTA 64 1.01.1.003, 1.01.1.004

64. ¿Cuál es el tratamiento de elección para una paciente joven sintomática con estenosis mitral reumática severa (área 1.1 cm²), valvas móviles sin calcificación y Score de Wilkins de 6 puntos?

A) Valvuloplastía mitral percutánea con balón
B) Reemplazo valvular mitral con prótesis mecánica
C) Comisurotomía quirúrgica a cielo abierto
D) Tratamiento exclusivo con Furosemida oral
E) Cierre percutáneo de la orejuela izquierda

PREGUNTA 65 1.01.1.004

65. Un paciente de 76 años, fumador de 80 paquetes-año, con EPOC severo en tratamiento con budesonida y salmeterol inhalados, presenta aumento de su disnea e intolerancia al ejercicio desde hace 7 días, asociado a edema de extremidades inferiores. Al examen Fsico 8ene frecuencia cardíaca 100 por minuto, presión arterial 110/70 mmHg e ingurgitación yugular a 45°. Se ausculta ritmo regular en dos tonos con ruidos apagados y murmullo pulmonar disminuido de manera bilateral, con roncus y sibilancias difusos. Se solicita ecocardiograma que muestra cavidades izquierdas con leve dilatación del ventrículo izquierdo y fracción de eyección conservada de 58%, y cavidades derechas dilatadas con paredes hipertróficas, con es8mación de presión de arteria pulmonar de 68 mmHg. Su radiograFa de tórax se muestra a con8nuación: ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Hipertensión pulmonar primaria
B) Insuficiencia cardíaca conges2va
C) Exacerbación de enfermedad pulmonar obstruc2va crónica
D) Cor pulmonale descompensado
E) Tromboembolismo pulmonar

PREGUNTA 66 1.01.1.010

66. Un paciente de 70 años consulta por disnea de medianos esfuerzos progresiva, asociada a ortopnea. Al examen físico tiene frecuencia cardíaca: 78 lpm, presión arterial: 130/80 mmHg, examen pulmonar con murmullo vesicular conservado y presencia de crépitos bibasales, examen cardíaco con ritmo irregular en dos tiempos, con presencia de soplo diastólico. Se palpa el choque de la punta en el quinto espacio intercostal línea medioclavicular y se observa edema en extremidades inferiores con signo de la fóvea. Su electrocardiograma muestra fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Estenosis aórtica
B) Estenosis pulmonar
C) Estenosis mitral
D) Insuficiencia aórtica
E) Insuficiencia pulmonar

PREGUNTA 67 1.01.1.005

67. Un paciente hipertenso y diabético se realiza un perfil lipídico, que muestra triglicéridos de 350 mg/dl, colesterol LDL de 230 mg/dl y colesterol HDL de 37. ¿Qué tratamiento debe indicarse?

A) Atorvastatina
B) Gemfibrozilo
C) Insulina
D) Lovastatina más gemfibrozilo
E) Ezetimibe

PREGUNTA 68 1.01.1.005

68. Mujer de 24 años consulta por palpitaciones ocasionales. Al examen físico se ausculta en el ápex un clic mesosistólico seguido de un soplo telesistólico. ¿Qué ocurre con este soplo al solicitarle a la paciente que se ponga de pie o realice una maniobra de Valsalva?

A) El clic y el soplo se adelantan y se vuelven más prolongados
B) El soplo desaparece por completo
C) El clic se desplaza hacia el segundo ruido y el soplo se acorta
D) No se produce ninguna modificación auscultatoria
E) Aparece un cuarto ruido cardíaco

PREGUNTA 69 1.01.1.005

69. ¿Cuál es la intervención quirúrgica de elección en un paciente con insuficiencia mitral primaria severa por rotura degenerativa de cuerdas tendinosas y FEVI del 55%?

A) Cirugía de reparación valvular (Plastía Mitral)
B) Reemplazo valvular mitral con prótesis biológica
C) Reemplazo valvular mitral con prótesis mecánica
D) Valvuloplastía mitral percutánea con balón
E) Cierre percutáneo de la comunicación interventricular

PREGUNTA 70 1.01.1.011

70. Mujer de 28 años asintomática. Al examen físico destaca un desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido cardíaco que no varía con la respiración y un soplo sistólico eyectivo en foco pulmonar. El ECG muestra bloqueo incompleto de rama derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Comunicación interauricular (CIA tipo ostium secundum)
B) Estenosis aórtica severa
C) Comunicación interventricular restrictiva
D) Ductus arterioso persistente
E) Tetralogía de Fallot corregida

PREGUNTA 71 1.01.1.011, 1.01.1.012, 1.01.1.013

71. Mujer de 28 años asintomática. Al examen físico destaca un desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido cardíaco que no varía con la respiración y un soplo sistólico eyectivo en foco pulmonar. El ECG muestra bloqueo incompleto de rama derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Comunicación interauricular (CIA tipo ostium secundum)
B) Estenosis aórtica severa
C) Comunicación interventricular restrictiva
D) Ductus arterioso persistente
E) Tetralogía de Fallot corregida

PREGUNTA 72 1.01.1.011, 1.01.1.012, 1.01.1.013

72. Hombre de 25 años en estudio por hipertensión arterial de difícil manejo. Al examen se pesquisan pulsos femorales marcadamente disminuidos en comparación con los radiales. La radiografía de tórax muestra erosiones óseas en el borde inferior de las costillas. ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Coartación aórtica
B) Feocromocitoma bilateral
C) Hiperaldosteronismo primario
D) Enfermedad de Takayasu
E) Estenosis de arteria renal aterosclerótica

PREGUNTA 73 1.01.1.014, 1.01.1.015

73. Hombre de 52 años hipertenso inicia tratamiento con Enalapril 20 mg al día. En el control a las 2 semanas se pesquisa elevación de la Creatinina plasmática desde 1.0 mg/dL basal hasta 2.4 mg/dL. A la auscultación abdominal se pesquisa un soplo sistólico en el flanco izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Estenosis de la arteria renal aterosclerótica
B) Hiperaldosteronismo primario (Conn)
C) Nefropatía diabética incipiente
D) Glomerulonefritis membranosa
E) Necrosis tubular aguda tóxica

PREGUNTA 74 1.01.1.014, 1.01.1.015

74. Mujer de 38 años consulta por crisis paroxísticas de cefalea pulsátil intensa, palpitaciones rápidas y sudoración profusa generalizada. Durante la consulta se registra PA de 210/120 mmHg y FC de 115 lpm. ¿Cuál es el examen de primera elección para el diagnóstico de esta condición?

A) Determinación de metanefrinas libres en plasma o fraccionadas en orina de 24 horas
B) Cortisol libre urinario en 24 horas
C) Relación aldosterona / renina plasmática
D) Ecocardiograma transesofágico
E) Resonancia magnética de cerebro y fosa posterior

PREGUNTA 75 1.01.1.015

75. Un paciente de 85 años, hipertenso, está en tratamiento con losartan 50 mg/12 horas y amlodipino 2,5 mg/día. Acude a control y refiere múltiples tomas de presión arterial, las que promedian 145/75 mmHg ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Aumentar la dosis de losartán a 100 mg/12 horas
B) Aumentar el amlodipino a 5 mg/día
C) Agregar atenolol 12,5 mg/día
D) Agregar hidroclorotiazida 25 mg/día
E) Mantener el tratamienti

PREGUNTA 76 1.01.1.015

76. Un paciente de 45 años, con IMC de 32 kg/m², acude a control médico, obje8vándose presión arterial de 146/92 mmHg. Se solicita Holter de presión arterial, que muestra múl8ples registros sobre 140/90 mmHg, diagnos8cándose hipertensión arterial. Sus exámenes de laboratorio resultan normales, incluyendo función renal, electrolitos plasmá8cos y electrocardiograma. ¿Qué 8po de fármacos es el más adecuado para iniciar el tratamiento an8hipertensivo en este paciente?

A) Bloqueadores alfa-adrenérgicos
B) Bloqueadores beta-adrenérgicos
C) Inhibidores del canal de calcio
D) Antagonistas del receptor de angiotensina
E) Diuré2cos 2azídicos

PREGUNTA 77 1.01.1.015

77. Hombre de 55 años hipertenso en tratamiento con enalapril, bien controlado. Consulta por tos seca persistente desde que inició el tratamiento hace 3 meses. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Amlodipino (mantener enalapril y agregar calcioantagonista)
B) Hidroclorotiazida (agregar diurético)
C) Losartán (cambiar enalapril por ARA II)
D) Atenolol (agregar betabloqueador)
E) Suspender enalapril sin reemplazar

PREGUNTA 78 1.01.1.015

78. Paciente con HTA en triple terapia (IECA, amlodipino, HCTZ), con edema en extremidades inferiores y presión 120/70. ¿Cuál es la conducta?

A) Agregar furosemida oral
B) Suspender amlodipino
C) Reducir dosis de IECA
D) Agregar espironolactona
E) Derivar a cardiología por insuficiencia cardíaca

PREGUNTA 79 1.01.1.015

79. Paciente con HTA sobre el rango normal en tratamiento actual, ¿cuál es el medicamento más adecuado a agregar?

A) Amlodipino
B) Valsartán (ARA II)
C) Hidroclorotiazida
D) Carvedilol
E) Furosemida

PREGUNTA 80 1.01.2.006

80. Hombre de 62 años consulta por cefalea leve sin otros síntomas. PA 210/115 mmHg. Examen físico neurológico, cardíaco y fondo de ojo completamente normales. ¿Cuál es la conducta médica más apropiada?

A) Indicar reposo y administrar antihipertensivo oral con control en 24-48 horas
B) Hospitalizar de inmediato en UCI e iniciar Nitroprusiato de sodio endovenoso
C) Administrar una cápsula de Nifedipino sublingual perforada
D) Realizar punción lumbar de urgencia para descartar hemorragia
E) Administrar Furosemida 80 mg endovenosa en bolo cada 4 horas

PREGUNTA 81 1.01.2.006

81. Paciente con Disección Aórtica aguda tipo A se presenta con PA 220/120 mmHg y FC 110 lpm. ¿Cuál es el objetivo hemodinámico y el tratamiento inicial de elección antes de ingresar a pabellón?

A) Labetalol endovenoso para alcanzar PAS < 120 mmHg y FC < 60 lpm en menos de 20 minutos
B) Nitroprusiato de sodio en monoterapia para bajar la PAM un 10% en 24 horas
C) Hidralazina endovenosa para mantener PAS alrededor de 160 mmHg
D) Furosemida endovenosa en bolo y reposo absoluto
E) Enalapril oral cada 8 horas hasta normalizar la presión

PREGUNTA 82 1.01.1.021

82. Un niño de 8 años acude a consulta por dificultad para seguir el ritmo en actividades físicas en la escuela, con infecciones respiratorias recurrentes. Signos vitales normales, auscultación pulmonar normal. A la auscultación cardiaca se detecta un soplo continuo de intensidad III/VI en la región paraesternal e infraclavicular izquierda. Talla -1 DE para su edad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Miocardiopatía hipertrófica
B) Comunicación interventricular
C) Comunicación interauricular
D) Ductus arterioso persistente
E) Soplo funcional

PREGUNTA 83 1.01.1.021, 1.01.1.022

83. Hombre de 26 años con pericarditis aguda viral. ¿Cuál es la terapia farmacológica de primera línea recomendada para tratar el episodio actual y reducir significativamente la tasa de recidiva a largo plazo?

A) Antiinflamatorios no esteroidales (AINEs) asociados a Colchicina durante 3 meses
B) Prednisona en dosis altas en monoterapia
C) Antibioticoterapia empírica con Ceftriaxona endovenosa
D) Anticoagulación con Heparina de bajo peso molecular
E) Paracetamol 500 mg cada 12 horas SOS

PREGUNTA 84 1.01.1.021, 1.01.1.022

84. Mujer de 55 años con cáncer pulmonar consulta por disnea severa y decaimiento. Al examen: PA 85/50 mmHg, ingurgitación yugular hasta el ángulo mandibular, ruidos cardíacos muy apagados y una caída de 18 mmHg de la presión arterial sistólica durante la inspiración. ¿Cuál es el procedimiento de urgencia indicado?

A) Pericardiocentesis evacuadora de urgencia
B) Administración de Furosemida 80 mg endovenosa
C) Cardioversión eléctrica sincronizada
D) Instalación de marcapaso transitorio
E) Infusión de Nitroglicerina a dosis altas

PREGUNTA 85 1.01.1.022

85. Un paciente de 40 años, con antecedente de reflujo gastroesofágico, consulta por dolor torácico de algunas horas de evolución, tipo puntada, muy intenso. Refiere que el dolor no respondió al uso de omeprazol. En su examen físico se aprecia adolorido, con FC: 76x', PA: 110/70 mmHg, ritmo regular en 2 tonos, sin soplos. Se solicita un electrocardiograma, que se muestra a continuación: Foto 8 (https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=86115). El diagnóstico más probable es:

A) Pericarditis aguda
B) Espasmo esofágico
C) Infarto miocárdico con supradesnivel del segmento ST de la pared lateral
D) Infarto miocárdico con supradesnivel del segmento ST de la pared inferior
E) Infarto miocárdico con supradesnivel del segmento ST de la pared inferolateral

PREGUNTA 86 1.01.1.023

86. Hombre de 59 años hipertenso ingresa con dolor torácico retroesternal transfixiante hacia la espalda. AngioTAC confirma Disección Aórtica que compromete la aorta ascendente extendiéndose hasta el arco aórtico (Stanford A). ¿Cuál es el tratamiento definitivo de elección?

A) Cirugía cardíaca de reemplazo aórtico de urgencia inmediata
B) Manejo médico conservador exclusivo en UCI con Betabloqueadores
C) Fibrinólisis endovenosa con Tenecteplase
D) Implante de Stent aórtico percutáneo electivo en 1 mes
E) Anticoagulación con Heparina no fraccionada en infusión

PREGUNTA 87 1.01.1.023, 1.01.1.024

87. Hombre de 59 años hipertenso ingresa con dolor torácico retroesternal transfixiante hacia la espalda. AngioTAC confirma Disección Aórtica que compromete la aorta ascendente extendiéndose hasta el arco aórtico (Stanford A). ¿Cuál es el tratamiento definitivo de elección?

A) Cirugía cardíaca de reemplazo aórtico de urgencia inmediata
B) Manejo médico conservador exclusivo en UCI con Betabloqueadores
C) Fibrinólisis endovenosa con Tenecteplase
D) Implante de Stent aórtico percutáneo electivo en 1 mes
E) Anticoagulación con Heparina no fraccionada en infusión

PREGUNTA 88 1.01.1.023, 1.01.1.024

88. Hombre de 68 años fumador asintomático es derivado por hallazgo ecográfico de un Aneurisma de Aorta Abdominal infrarrenal de 5.8 cm de diámetro transversal máximo. ¿Cuál es la conducta médica indicada?

A) Derivación a cirugía vascular para resolución quirúrgica o endovascular (EVAR)
B) Control ecográfico anual para vigilar crecimiento
C) Iniciar anticoagulación oral con Warfarina
D) Indicar reposo en cama permanente
E) Tratamiento con dosis altas de estatinas sin intervención

PREGUNTA 89 1.01.1.026, 1.01.2.008

89. **Mujer de 68 años con antecedente de reemplazo total de cadera hace 10 días presenta disnea súbita y taquicardia de 115 lpm. El cálculo del Score de Wells arroja 7 puntos (probabilidad alta). ¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada?**

A) Solicitar AngioTAC de arterias pulmonares con contraste endovenoso

B) Solicitar Dímero D plasmático por técnica ELISA

C) Tomar radiografía de tórax y si es normal descartar el cuadro

D) Solicitar ecocardiograma transtorácico ambulatorio

E) Realizar prueba de esfuerzo convencional

PREGUNTA 90 1.01.1.026, 1.01.2.008

90. **Hombre de 54 años con TEP confirmado evoluciona bruscamente con PA de 70/40 mmHg, frialdad distal y signos de shock obstructivo. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea que debe indicarse de inmediato?**

A) Fibrinólisis sistémica con Alteplasa (rt-PA 100 mg endovenoso)

B) Anticoagulación exclusiva con Apixabán oral

C) Instalación de filtro de vena cava inferior

D) Infusión de nitroglicerina a dosis crecientes

E) Administración de Furosemida 80 mg endovenosa

SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

BLOQUE 1 ARRITMIAS, CONDUCCIÓN & URGENCIAS ELÉCTRICAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 1 Respuesta: A

Lectura Sistemática del ECG en Urgencias y APS

1.01.4.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Un QTc > 500 ms representa un riesgo crítico de inducir Torsades de Pointes y fibrilación ventricular. La medida mandatoria es suspender inmediatamente el fármaco causante (los macrólidos como la claritromicina prolongan el QT), monitorizar el ritmo cardíaco y asegurar niveles plasmáticos normales de potasio y magnesio. La amiodarona prolongaría aún más el QT y está contraindicada.

PREGUNTA 2 Respuesta: A

Lectura Sistemática del ECG en Urgencias y APS

1.01.4.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

En el ritmo sinusal normal, la despolarización auricular se origina en el nodo sinusal (ubicado en la parte alta de la aurícula derecha) y se dirige hacia abajo y a la izquierda. Por ende, la onda P DEBE ser positiva en DII, DIII y aVF, y negativa en aVR. Una onda P negativa en DII indica un ritmo auricular bajo o ectópico.

PREGUNTA 3 Respuesta: B

Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL

1.01.2.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

Iniciar compresiones torácicas externas (RCP)

PREGUNTA 4 Respuesta: A

Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL

1.01.2.006, 1.01.3.002, 1.01.3.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

La regla de oro del ACLS establece que inmediatamente después de administrar una descarga eléctrica, se deben reanudar las compresiones torácicas durante 2 minutos completos sin interrumpir para verificar el ritmo o el pulso. Chequear el pulso inmediatamente después del choque genera pausas innecesarias y el corazón recién desfibrilado requiere soporte hemodinámico mediante compresiones para recuperar el gasto cardíaco.

PREGUNTA 5 Respuesta: A

Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL

1.01.2.006, 1.01.3.002, 1.01.3.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

La asistolia es un ritmo no desfibrilable. La aplicación de descargas eléctricas en asistolia no tiene utilidad fisiológica, produce daño térmico miocárdico adicional y retrasa las compresiones torácicas efectivas, por lo que está formalmente contraindicada.

PREGUNTA 6 Respuesta: E

Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL)

1.01.1.012 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Los betabloqueantes empeoran el EPOC (que se trata con beta-agonistas).

PREGUNTA 7 **Respuesta: A**

1.01.1.012, 1.01.1.013, 1.01.1.014, 1.01.3.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL)

La paciente presenta un puntaje CHA_2DS_2-VASc de 5 (Edad ≥ 75: 2 pts, HTA: 1 pt, DM: 1 pt, Sexo femenino: 1 pt), lo que confiere un riesgo tromboembólico anual > 6-8%. La indicación obligatoria según guías MINSAL y protocolos GES es la Anticoagulación Oral continua con DOACs (Apixabán, Rivaroxabán o Dabigatrán). La aspirina no previene el ACV embólico y no debe utilizarse.

PREGUNTA 8 **Respuesta: A**

1.01.1.012, 1.01.1.013, 1.01.1.014, 1.01.3.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL)

Las prótesis valvulares cardíacas mecánicas constituyen una contraindicación absoluta para el uso de DOACs (ensayos clínicos demostraron mayor tasa de trombosis protésica y sangrado con dabigatrán/rivaroxabán). El único tratamiento anticoagulante validado y seguro son los antagonistas de vitamina K (Acenocumarol/Warfarina) con meta de INR estricta de 2.5 a 3.5 para válvulas mecánicas mitrales.

PREGUNTA 9 **Respuesta: A**

1.01.1.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL)

FA con respuesta ventricular rápida estable y FEVI conservada: control de frecuencia con betabloqueador (metoprolol) o calcioantagonista (diltiazem/verapamilo). Metoprolol es primera línea.

PREGUNTA 10 **Respuesta: C**

1.01.1.014 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL)

En las últimas dos derivaciones se ven claramente las ondas de serrucho (que aparecen con la maniobra vagal, ya que bradicardiza y aumenta el bloqueo AV), características del flutter.

PREGUNTA 11 **Respuesta: D**

1.01.1.024 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

TPSV & Síndrome de Wolff-Parkinson-White

Tiene una TPSV clásica. El tratamiento de primera línea son las maniobras vagales (ej. Valsalva modificado es la más recomendada en adultos y niños que cooperan; en niños pequeño se prefiere la inmersión facial en agua fría. El masaje caroVdeo se puede usar en adultos, pero no se recomienda en niños ni en adultos mayores con riesgo de ateroma caroVdeo que se pueda soltar). De segunda línea se uGlizan fármacos, siendo de elección la adenosina en bolo EV de 6 mg. Si falla, se dan hasta dos nuevas dosis de 12 mg. Si vuelve a fallar, se usa el verapamilo (contraindicado en falla cardíaca e hipotensión). Como toda taquiarritmia, si está hemodinámicamente inestable, de primera línea se maneja con cardioversión eléctrica.

PREGUNTA 12 **Respuesta: A**

1.01.1.024, 1.01.2.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

TPSV & Síndrome de Wolff-Parkinson-White

La Adenosina tiene una vida media ultracorta (< 10 segundos). Para que alcance concentraciones terapéuticas en el nodo AV, debe inyectarse en bolo ultrarrápido (1-2 segundos) en una vena periférica proximal, seguido de un bolo de lavado de 20 mL de solución fisiológica y elevación del brazo. La dosis inicial es de 6 mg.

PREGUNTA 13 **Respuesta: A**

1.01.1.024, 1.01.2.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

TPSV & Síndrome de Wolff-Parkinson-White

El Verapamilo es un bloqueador de los canales de calcio no dihidropiridínico que bloquea la conducción en el nodo auriculoventricular sin afectar la vía accesoria. Al suprimir el freno nodal, los impulsos auriculares caóticos pasan sin resistencia por la vía accesoria rápida hacia los ventrículos, gatillando Fibrilación Ventricular.

PREGUNTA 14 **Respuesta: A**

1.01.2.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

TPSV & Síndrome de Wolff-Parkinson-White

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 158). Evalúa el manejo clínico de Taponamiento pericárdico según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 15 **Respuesta: D**

1.01.1.002 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Bradicardias Sintomáticas & Bloqueos AV (GES Marcapasos)

Se observa con disociación AV y, además, la FC cercana a 30 sugiere mucho un BAV completo o de tercer grado. Se deben saber identificar todas las arritmias de manera relativamente rápido en el EKG.

PREGUNTA 16 **Respuesta: A**

1.01.1.002, 1.01.2.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Bradicardias Sintomáticas & Bloqueos AV (GES Marcapasos)

El bloqueo intermitente de ondas P sin prolongación previa del intervalo PR define un Bloqueo AV de 2° Grado Mobitz II. Debido a que la lesión se encuentra en el sistema His-Purkinje infranodal, existe un alto riesgo de progresión a bloqueo completo y muerte súbita, por lo que tiene indicación formal de Marcapaso Definitivo.

PREGUNTA 17 **Respuesta: A**

1.01.1.002, 1.01.2.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Bradicardias Sintomáticas & Bloqueos AV (GES Marcapasos)

En una bradiarritmia con inestabilidad hemodinámica que no responde a la dosis inicial de atropina, la conducta de emergencia perentoria es la estimulación eléctrica mediante marcapaso transcutáneo externo asociada al inicio de drogas vasoactivas (Adrenalina o Dopamina) mientras se prepara el marcapaso transvenoso.

PREGUNTA 18 **Respuesta: E**

1.01.2.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Bradicardias Sintomáticas & Bloqueos AV (GES Marcapasos)

Por tener compromiso hemodinámico, da igual de qué taquiarritmia se trate y se debe cardiovertir eléctricamente (no confundir con la desfibrilación, que se usa en el paro con FV o TVSP).

BLOQUE 2 CARDIOPATÍA CORONARIA & SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 19 **Respuesta: D**

1.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Angina Crónica Estable & Estratificación de Riesgo Funcional

La angina estable con test de esfuerzo alterado, se estudia con coronariografía.

PREGUNTA 20 **Respuesta: A**

1.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Angina Crónica Estable & Estratificación de Riesgo Funcional

En un paciente con sospecha de angina crónica estable, capaz de realizar ejercicio físico y con un ECG basal normal e interpretable, la prueba no invasiva de primera elección recomendada por el MINSAL y consensos internacionales es el Test de Esfuerzo Convencional (Ergometría). Permite confirmar la presencia de isquemia miocárdica inducible, cuantificar el umbral isquémico en METs y estratificar el riesgo cardiovascular global.

PREGUNTA 21 **Respuesta: A**

1.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Angina Crónica Estable & Estratificación de Riesgo Funcional

Las estatinas de alta potencia (Atorvastatina 40-80 mg/día o Rosuvastatina 20-40 mg/día) y la Aspirina son los dos pilares farmacológicos que han demostrado modificar la historia natural de la cardiopatía coronaria, estabilizando las placas de ateroma y reduciendo significativamente la mortalidad cardiovascular. Los nitratos, calcioantagonistas y trimetazidina son fármacos antianginosos sintomáticos que mejoran la tolerancia al esfuerzo pero no modifican la sobrevida.

PREGUNTA 22 **Respuesta: A**

1.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Angina Crónica Estable & Estratificación de Riesgo Funcional

La única opción aceptable era la angina de reciente comienzo.

PREGUNTA 23 **Respuesta: D**

1.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Angina Crónica Estable & Estratificación de Riesgo Funcional

Es una angina crónica estable. Su diagnóstico es clínico y su estudio comienza con una prueba de esfuerzo, generalmente el ECG de esfuerzo. En los casos en que no se puede realizar (amputados o pacientes que no toleran el ejercicio) y en los casos en que el electrocardiograma es ilegible (ej. BCRI), se uGlizan otras pruebas de esfuerzo, como la ecocardiografía, con dobutamina o la cintigrafía cardiaca con talio y dipiridamol. Si alguna de estas pruebas de esfuerzo resulta alterada, se procede a la coronariografía para determinar la vía de revascularización. La regla general es que se uGlice un stent cuando hay compromiso de uno o dos vasos, y se uGlice un bypass coronario cuando hay compromiso de tres vasos o de dos vasos incluyendo la arteria descendente anterior (ADA).

PREGUNTA 24 **Respuesta: B**

1.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Angina Crónica Estable & Estratificación de Riesgo Funcional

Lo más importante en la angina crónica es revascularizar (se pide test de esfuerzo y luego angiografía, para hacer angioplastía o bypass) y, además, dejar las estatinas y sobre todo la aspirina. Sin embargo, además, sirven los nitritos, como el isosorbide o la nitroglicerina. Los demás son antihipertensivos o fármacos para la insuficiencia cardíaca.

PREGUNTA 25 **Respuesta: B**

1.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Angina Crónica Estable & Estratificación de Riesgo Funcional

Caso clínico oficial EUNACOM para Angina crónica estable.

PREGUNTA 26 **Respuesta: C**

1.01.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

SCASEST: Angina Inestable e IAM sin Supradesnivel del ST

Es una miocardiopatía hipertrófica clásica (síncope, antecedentes de muerte súbita en la familia, soplo eyectivo y clínica de insuficiencia cardiaca). Veremos en detalle toda la semiología cardíaca.

PREGUNTA 27 **Respuesta: A**

1.01.1.020, 1.01.2.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

SCASEST: Angina Inestable e IAM sin Supradesnivel del ST

El pilar farmacológico del SCASEST confirmado es la triple terapia antitrombótica inicial: doble antiagregación plaquetaria (Aspirina + Ticagrelor) asociada a anticoagulación parenteral (Enoxaparina). La trombólisis farmacológica está formalmente CONTRAINDICADA en el SCASEST (solo se usa en SCACEST con supradesnivel del ST).

PREGUNTA 28 **Respuesta: A**

1.01.1.020, 1.01.2.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

SCASEST: Angina Inestable e IAM sin Supradesnivel del ST

La coronariografía inmediata (< 2 horas) se reserva para pacientes con criterios de muy alto riesgo isquémico o inestabilidad: shock cardiogénico, inestabilidad hemodinámica, dolor torácico refractario a nitratos/analgesia, arritmias ventriculares malignas o insuficiencia cardíaca aguda secundaria a isquemia.

PREGUNTA 29 **Respuesta: A**

1.01.2.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

SCASEST: Angina Inestable e IAM sin Supradesnivel del ST

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 43). Evalúa el manejo clínico de Angina inestable según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 30 **Respuesta: B**

1.01.2.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

SCACEST: IAM con Supradesnivel del ST & Protocolo Reperfusión GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 98). Evalúa el manejo clínico de Disección aórtica según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 31 **Respuesta: A**

1.01.2.002, 1.01.3.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

SCACEST: IAM con Supradesnivel del ST & Protocolo Reperfusión GES

Cuando el tiempo para realizar una angioplastía primaria supera los 120 minutos, la guía GES y las normas internacionales obligan a realizar fibrinólisis farmacológica inmediata con Tenecteplase en menos de 30 minutos desde el ingreso para salvar miocardio y reducir la mortalidad.

PREGUNTA 32 **Respuesta: A**

1.01.2.002, 1.01.3.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

SCACEST: IAM con Supradesnivel del ST & Protocolo Reperfusión GES

El paciente presenta un infarto del ventrículo derecho confirmado por V4R positivo. El ventrículo derecho infartado se vuelve rígido y depende críticamente de una presión de llenado elevada (precarga) para mantener el gasto cardíaco. El tratamiento de elección de la hipotensión es la expansión volumétrica agresiva con suero fisiológico. Los nitratos y diuréticos reducen la precarga y causan colapso circulatorio irreversible.

PREGUNTA 33 **Respuesta: A**

1.01.1.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Complicaciones Mecánicas del IAM & Angina de Prinzmetal

La presencia de un soplo pansistólico rudo en el borde esternal izquierdo bajo asociado a un frémito palpable (sensación táctil de turbulencia) tras varios días de un infarto es patognomónica de la Rotura del Tabique Interventricular.

PREGUNTA 34 **Respuesta: A**

1.01.1.008, 1.01.1.009, 1.01.1.025 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Complicaciones Mecánicas del IAM & Angina de Prinzmetal

La presencia de un soplo pansistólico rudo en el borde esternal izquierdo bajo asociado a un frémito palpable (sensación táctil de turbulencia) tras varios días de un infarto es patognomónica de la Rotura del Tabique Interventricular.

PREGUNTA 35 **Respuesta: A**

1.01.1.008, 1.01.1.009, 1.01.1.025 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Complicaciones Mecánicas del IAM & Angina de Prinzmetal

El cuadro clínico corresponde a una Angina Vasoespástica (Angina de Prinzmetal). Los fármacos de primera línea para prevenir nuevos episodios son los antagonistas del calcio (Amlodipino, Diltiazem o Verapamilo). Los betabloqueadores están estrictamente contraindicados.

PREGUNTA 36 **Respuesta: A**

Complicaciones Mecánicas del IAM & Angina de Prinzmetal

1.01.1.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una estenosis aórtica clásica. De verdad hay que leer y aprenderse el resumen de semiología cardíaca.

BLOQUE 3 INSUFICIENCIA CARDÍACA, MIOCARDIOPATÍAS & SHOCK · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 37 **Respuesta: A**

Insuficiencia Cardíaca Crónica: Fenotipos, Diagnóstico & Criterios Framingham

1.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El paciente presenta 4 criterios mayores de Framingham (ortopnea, ingurgitación yugular, galope por R3 y crépitos pulmonares bilaterales), lo que confirma con certeza absoluta el diagnóstico clínico de Insuficiencia Cardíaca Congestiva.

PREGUNTA 38 **Respuesta: A**

Insuficiencia Cardíaca Crónica: Fenotipos, Diagnóstico & Criterios Framingham

1.01.1.006, 1.01.1.007 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El paciente presenta 4 criterios mayores de Framingham (ortopnea, ingurgitación yugular, galope por R3 y crépitos pulmonares bilaterales), lo que confirma con certeza absoluta el diagnóstico clínico de Insuficiencia Cardíaca Congestiva.

PREGUNTA 39 **Respuesta: A**

Insuficiencia Cardíaca Crónica: Fenotipos, Diagnóstico & Criterios Framingham

1.01.1.006, 1.01.1.007 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Los péptidos natriuréticos (BNP < 100 pg/mL o NT-proBNP < 300 pg/mL) poseen un valor predictivo negativo superior al 98%: un valor normal descarta la insuficiencia cardíaca descompensada como causa de la disnea en el servicio de urgencia.

PREGUNTA 40 **Respuesta: A**

Insuficiencia Cardíaca Crónica: Fenotipos, Diagnóstico & Criterios Framingham

1.01.1.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Se sospecha un endocarditis bacteriana subaguda (mayor a 7 días), por lo que se debe pedir hemocultivos y ecocardiografía.

PREGUNTA 41 **Respuesta: A**

Cuádruple Terapia GDMT en IC-FEr (Guía GES 2026)

1.01.1.006, 1.01.1.007 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La inhibición simultánea de la ECA y de la neprilisina produce una acumulación masiva de bradicinina que puede desencadenar un angioedema orofaríngeo fatal. Por ende, se exige un período de lavado de al menos 36 horas tras la última dosis de IECA antes de iniciar Sacubitrilo/Valsartán.

PREGUNTA 42 **Respuesta: A**

Cuádruple Terapia GDMT en IC-FEr (Guía GES 2026)

1.01.1.006, 1.01.1.007 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La Furosemida es un diurético de asa sintomático esencial para aliviar la sobrecarga de volumen y edemas, pero no modifica la historia natural ni disminuye la mortalidad. Los 4 fármacos que sí reducen mortalidad son: ARNI, Betabloqueadores, ARM e iSGLT2.

PREGUNTA 43 **Respuesta: A**

Edema Agudo de Pulmón & Cuadrícula de Forrester

1.01.2.007 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

La Ventilación No Invasiva (VNI) en modalidad CPAP es la medida más costo-efectiva y de primera línea en el edema agudo de pulmón cardiogénico: recluta alvéolos inundados de líquido, mejora la oxigenación y reduce la precarga y poscarga, disminuyendo drásticamente la tasa de intubación endotraqueal.

PREGUNTA 44 **Respuesta: A**

Edema Agudo de Pulmón & Cuadrícula de Forrester

1.01.2.007 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

La nitroglicerina endovenosa es el vasodilatador de primera línea: produce venodilatación potente a dosis bajas (reduciendo la precarga) y vasodilatación arterial a dosis más altas (reduciendo la poscarga), aliviando de forma casi inmediata la congestión pulmonar.

PREGUNTA 45 **Respuesta: A**

Shock Cardiogénico & Diagnóstico Diferencial de los 4 Shocks

1.01.2.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

La Noradrenalina es el vasopresor de primera línea en el shock cardiogénico: posee un potente efecto alfa-1 vasoconstrictor y un moderado efecto beta-1 inótropo, logrando elevar la PAM con significativamente menor riesgo de taquiarritmias y menor mortalidad comparada con la Dopamina.

PREGUNTA 46 **Respuesta: A**

Shock Cardiogénico & Diagnóstico Diferencial de los 4 Shocks

1.01.2.003, 1.01.2.004, 1.01.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

La Noradrenalina es el vasopresor de primera línea en el shock cardiogénico: posee un potente efecto alfa-1 vasoconstrictor y un moderado efecto beta-1 inótropo, logrando elevar la PAM con significativamente menor riesgo de taquiarritmias y menor mortalidad comparada con la Dopamina.

PREGUNTA 47 **Respuesta: A**

Shock Cardiogénico & Diagnóstico Diferencial de los 4 Shocks

1.01.2.003, 1.01.2.004, 1.01.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

El patrón hemodinámico caracterizado por Gasto Cardíaco elevado (fase hiperdinámica) con Resistencia Vascular Sistémica baja (vasoplejía periférica por mediadores inflamatorios) es exclusivo del Shock Distributivo (Séptico, Anafiláctico o Neurogénico).

PREGUNTA 48 **Respuesta: E**

Shock Cardiogénico & Diagnóstico Diferencial de los 4 Shocks

1.01.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Es un SCA con SDST, por lo que requiere angioplastía de urgencia (o trombolisis, que no aparecía en las opciones).

PREGUNTA 49 **Respuesta: D**

Shock Cardiogénico & Diagnóstico Diferencial de los 4 Shocks

1.01.2.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 88). Evalúa el manejo clínico de Insuficiencia cardíaca aguda según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 50 **Respuesta: E**

Miocardiopatías (Hipertrófica, Dilatada, Restrictiva & Miocarditis)

1.01.1.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Agregar espironolactona e iniciar estudio de HTA secundaria

PREGUNTA 51 **Respuesta: A**

Miocardiopatías (Hipertrófica, Dilatada, Restrictiva & Miocarditis)

1.01.1.016, 1.01.1.017, 1.01.1.018, 1.01.1.019 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El soplo de la Miocardiopatía Hipertrófica es el único soplo sistólico eyectivo (junto al prolapso mitral) que aumenta de intensidad con maniobras que reducen el llenado ventricular (Valsalva o ponerse de pie) y disminuye con maniobras que aumentan el volumen ventricular (cuclillas o handgrip).

PREGUNTA 52 **Respuesta: C**

Miocardiopatías (Hipertrófica, Dilatada, Restrictiva & Miocarditis)

1.01.1.017 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una insuficiencia aórtica clásica.

PREGUNTA 53 **Respuesta: D**

Miocardiopatías (Hipertrófica, Dilatada, Restrictiva & Miocarditis)

1.01.1.018 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Insuficiencia Cardíaca Congestiva: Los medicamentos que aumentan la supervivencia en la insuficiencia cardíaca congestiva son los IECA o ARA II, betabloqueantes (idealmente carvedilol) y espironolactona. El manejo de la patología de base también es fundamental. El losartán no se usa en este caso porque el paciente ya toma enalapril, que cumple la misma función.

PREGUNTA 54 **Respuesta: A**

Miocardiopatías (Hipertrófica, Dilatada, Restrictiva & Miocarditis)

1.01.1.019 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una insuficiencia mitral clásica, con clínica de insuficiencia cardiaca izquierda (disnea y crépitos), soplo holosistólico y desplazamiento del choque de la punta, que sugiere cardiomegalia. Revisar resumen de semiología cardiaca.

BLOQUE 4 VALVULOPATÍAS & SEMIOLOGÍA CARDIOVASCULAR · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 55 **Respuesta: A**

Estenosis Aórtica: Semiología, Severidad & TAVI vs SAVR (Guía GES)

1.01.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

El paciente tiene una Estenosis Aórtica Severa Sintomática (AVA < 1.0 cm² y gradiente > 40 mmHg). La aparición de síntomas es una indicación formal de reemplazo valvular (TAVI en ancianos o cirugía en jóvenes) para evitar la muerte súbita y mejorar el pronóstico.

PREGUNTA 56 **Respuesta: A**

Estenosis Aórtica: Semiología, Severidad & TAVI vs SAVR (Guía GES)

1.01.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

En pacientes menores de 65 años, la causa más frecuente de estenosis aórtica aislada es la calcificación acelerada sobre una válvula aórtica bicúspide congénita. En mayores de 70 años predomina la calcificación senil degenerativa.

PREGUNTA 57 **Respuesta: A**

Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática

1.01.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 3). Evalúa el manejo clínico de Cardiopatía congénita en adulto según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 58 **Respuesta: D**

Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática

1.01.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

CIA: soplo sistólico de eyección en foco pulmonar (por hiperflujo pulmonar) + desdoblamiento FIJO del S2 (por sobrecarga de volumen en VD independiente de la respiración) = signo casi patognomónico de CIA. Suele diagnosticarse en embarazo por el aumento del gasto cardíaco.

PREGUNTA 59 **Respuesta: A**

Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática

1.01.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una CIA clásica, por la dilatación derecha y el desdoblamiento fijo del 2º ruido.

PREGUNTA 60 **Respuesta: A**

Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática

1.01.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Era una clásica CIA del adulto, con toda su clínica, excepto el desdoblamiento fijo del R2.

PREGUNTA 61 **Respuesta: A**

Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática

1.01.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una CIA (comunicación interauricular) clásica, aunque en un adulto: soplo sistólico eyectivo, desdoblamiento del segundo ruido y eje desviado a derecha.

PREGUNTA 62 **Respuesta: B**

Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática

1.01.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Cuadro clásico

PREGUNTA 63 **Respuesta: A**

Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática

1.01.1.003, 1.01.1.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

La presión diferencial sumamente amplia (170/45 mmHg) asociada al pulso saltón o de Corrigan y a signos periféricos hiperdinámicos (Musset, Quincke) es patognomónica de la Insuficiencia Aórtica Crónica Severa.

PREGUNTA 64 **Respuesta: A**

Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática

1.01.1.003, 1.01.1.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

En la estenosis mitral severa con anatomía valvular favorable definida por un Score de Wilkins ≤ 8 puntos (valvas móviles, poco engrosadas y sin calcificación comisural severa ni insuficiencia mitral significativa), la Valvuloplastía Mitral Percutánea con Balón es el tratamiento de primera elección por su alta eficacia y mínima invasividad.

PREGUNTA 65 **Respuesta: D**

Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática

1.01.1.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene síntomas de insuficiencia cardíaca derecha: astenia, edema, yugulares ingurgitadas. En el ecocardiograma se confirma la hipertrofia derecha y la hipertensión pulmonar (PAP > 25 mmHg), que no es primaria, sino secundaria al EPOC. Por tanto, es un cor pulmonar clásico. No Gene una insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), que se refiere a la ICC izquierda, con tendencia al edema pulmonar. La radiografía muestra campos pulmonares grandes, con corazón en gota, clásico del EPOC avanzado. Fuente imagen: hxps://li~l.com/.

PREGUNTA 66 **Respuesta: C**

Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática

1.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Estenosis Mitral: El cuadro clínico es compatible con estenosis mitral. Se recomienda repasar la semiología cardíaca.

PREGUNTA 67 **Respuesta: A**

Insuficiencia Mitral Orgánica/Funcional & Prolapso Valvular Mitral (Barlow)

1.01.1.005 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El LDL es la prioridad (a menos que los triglicéridos estén mayores a 500). Las estatinas están indicadas de inmediato cuando el LDL es mayor a 190 en pacientes de bajo riesgo CV o cuando es mayor a 100 en los diabéticos. Además cuando continúa alto el LDL, a pesar de 3 meses con dieta. Los médicos generales no deben indicar estatinas y gemfibrozilo juntos.

PREGUNTA 68 **Respuesta: A**

Insuficiencia Mitral Orgánica/Funcional & Prolapso Valvular Mitral (Barlow)

1.01.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

Al realizar la maniobra de Valsalva o ponerse de pie, disminuye el retorno venoso y el volumen del ventrículo izquierdo se reduce. En un ventrículo más pequeño, las valvas mitrales redundantes prolapsan antes durante la eyección sistólica, por lo que el clic se produce más temprano y el soplo se hace más precoz y duradero.

PREGUNTA 69 **Respuesta: A**

Insuficiencia Mitral Orgánica/Funcional & Prolapso Valvular Mitral (Barlow)

1.01.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

En la insuficiencia mitral orgánica degenerativa, la Plastía Mitral (reparación de valvas y cuerdas con anillo de anuloplastía) es la técnica de elección superior al reemplazo protésico, ya que preserva la geometría y contractilidad del ventrículo izquierdo y evita la anticoagulación crónica de por vida.

PREGUNTA 70 **Respuesta: A**

Semiología de Soplos, Maniobras Dinámicas & Cardiopatías Congénitas del Adulto

1.01.1.011 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El desdoblamiento amplio y FIJO del segundo ruido (que no cambia de intervalo durante la inspiración ni espiración) asociado a un soplo de hiperflujo pulmonar y bloqueo de rama derecha es el hallazgo patognomónico de la Comunicación Interauricular (CIA).

PREGUNTA 71 **Respuesta: A**

Semiología de Soplos, Maniobras Dinámicas & Cardiopatías Congénitas del Adulto

1.01.1.011, 1.01.1.012, 1.01.1.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El desdoblamiento amplio y FIJO del segundo ruido (que no cambia de intervalo durante la inspiración ni espiración) asociado a un soplo de hiperflujo pulmonar y bloqueo de rama derecha es el hallazgo patognomónico de la Comunicación Interauricular (CIA).

PREGUNTA 72 **Respuesta: A**

Semiología de Soplos, Maniobras Dinámicas & Cardiopatías Congénitas del Adulto

1.01.1.011, 1.01.1.012, 1.01.1.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La Coartación Aórtica se presenta típicamente como hipertensión arterial en pacientes jóvenes con marcada asimetría de pulsos (braquiales fuertes vs femorales débiles) y signo radiológico de Roesler (muescas costales por dilatación de arterias intercostales colaterales).

BLOQUE 5 HTA, PATOLOGÍA VASCULAR & PERICARDIO · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 73 **Respuesta: A**

Hipertensión Arterial Esencial & Secundaria: Diagnóstico, Metas GES & Terapia Dual

1.01.1.014, 1.01.1.015 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El deterioro brusco de la función renal (alza de creatinina > 30-50%) tras la introducción de un IECA o ARA2, sumado a la auscultación de un soplo abdominal en el flanco, es patognomónico de la Estenosis Bilateral de la Arteria Renal o unilateral en riñón único, al eliminarse la vasoconstricción de la arteriola eferente mediada por angiotensina II.

PREGUNTA 74 **Respuesta: A**

Hipertensión Arterial Esencial & Secundaria: Diagnóstico, Metas GES & Terapia Dual

1.01.1.014, 1.01.1.015 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La tríada clásica de cefalea + sudoración + palpitaciones con crisis hipertensivas paroxísticas es altamente específica de Feocromocitoma. El método de tamizaje de primera elección con mayor sensibilidad (> 97%) es la cuantificación de metanefrinas plasmáticas u urinarias.

PREGUNTA 75 **Respuesta: E**

1.01.1.015 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Hipertensión Arterial Esencial & Secundaria: Diagnóstico, Metas GES & Terapia Dual

Por su edad, está bien controlado, ya que la meta es que sea menor a 150/90 mmHg.

PREGUNTA 76 **Respuesta: D**

1.01.1.015 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

Hipertensión Arterial Esencial & Secundaria: Diagnóstico, Metas GES & Terapia Dual

Además de obesidad, con alta probabilidad Gene una hipertensión esencial, ya que no Gene elementos que hagan sospechar una causa secundaria. En pacientes jóvenes se suele iniciar con IECA (inhibidores de la enzima converGdora de angiotensina) o ARA2 (antagonistas del receptor de angiotensina 2). Muchas guías actuales prefieren iniciar con dos fármacos de forma simultánea (ej. losartán + amlodipino). Aunque IECA y ARA2 Genen resultados comparables, muchos pacientes prefieren el losartán sobre el enalapril, debido a que se toma una vez al día.

PREGUNTA 77 **Respuesta: C**

1.01.1.015 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

Hipertensión Arterial Esencial & Secundaria: Diagnóstico, Metas GES & Terapia Dual

Tos seca por IECA (enalapril): efecto de clase por acumulación de bradicinina, ocurre en 10-15% de pacientes. Solución: cambiar a ARA II (Losartán, Valsartán) que no causan tos. El control hipertensivo se mantiene con igual eficacia sin el efecto adverso.

PREGUNTA 78 **Respuesta: B**

1.01.1.015 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

Hipertensión Arterial Esencial & Secundaria: Diagnóstico, Metas GES & Terapia Dual

Suspender amlodipino

PREGUNTA 79 **Respuesta: B**

1.01.1.015 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

Hipertensión Arterial Esencial & Secundaria: Diagnóstico, Metas GES & Terapia Dual

Valsartán (ARA II)

PREGUNTA 80 **Respuesta: A**

1.01.2.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Crisis Hipertensivas: Urgencia vs Emergencia Hipertensiva

Se trata de una Urgencia Hipertensiva (alza tensional severa sin daño de órgano blanco). El manejo correcto es el reposo inicial seguido de antihipertensivos orales y control ambulatorio en 24-48 horas. No requiere hospitalización en UCI ni nitroprusiato EV. El nifedipino sublingual está contraindicado.

PREGUNTA 81 **Respuesta: A**

1.01.2.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Crisis Hipertensivas: Urgencia vs Emergencia Hipertensiva

En la Disección Aórtica Aguda (emergencia hipertensiva hiperaguda), el objetivo vital es reducir drásticamente el estrés de cizallamiento sobre la pared aórtica (dP/dt). Se debe reducir de inmediato la PAS a < 120 mmHg y la FC a < 60 lpm en < 20 minutos usando Betabloqueadores endovenosos (Labetalol) como primera línea, asociando vasodilatadores si es necesario.

PREGUNTA 82 **Respuesta: D**

1.01.1.021 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Pericarditis Aguda & Taponamiento Cardíaco

Ductus Arterioso Persistente: El soplo continuo (maquinaria) es característico del ductus arterioso persistente. Se recomienda revisar el resumen de semiología cardíaca.

PREGUNTA 83 **Respuesta: A**

Pericarditis Aguda & Taponamiento Cardíaco

1.01.1.021, 1.01.1.022 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

Las guías internacionales de la ESC y consensos clínicos establecen que el tratamiento estándar de primera línea de la pericarditis aguda es la asociación de AINEs (Ibuprofeno o Aspirina en dosis altas) con Colchicina durante 3 meses, debido a que la adición de colchicina disminuye a la mitad la tasa de recurrencias y recidivas.

PREGUNTA 84 **Respuesta: A**

Pericarditis Aguda & Taponamiento Cardíaco

1.01.1.021, 1.01.1.022 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

La paciente presenta un Taponamiento Cardíaco Neoplásico clásico (Tríada de Beck completa: hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos apagados, más Pulso Paradojal severo > 10 mmHg). El único tratamiento salvavidas de emergencia es la evacuación inmediata del líquido mediante Pericardiocentesis.

PREGUNTA 85 **Respuesta: A**

Pericarditis Aguda & Taponamiento Cardíaco

1.01.1.022 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere | GES

Es una pericarditis clásica, tanto por la clínica, como por el EKG con SDST en J en casi todas las derivaciones.

PREGUNTA 86 **Respuesta: A**

Patología de la Aorta: Disección Aórtica Aguda & Aneurisma de Aorta Abdominal

1.01.1.023 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

Toda Disección Aórtica Stanford A (que compromete la aorta ascendente) es una emergencia quirúrgica absoluta que exige resolución quirúrgica inmediata a tórax abierto para reemplazar el segmento disecado y evitar la muerte por rotura intrapericárdica, taponamiento o infarto masivo.

PREGUNTA 87 **Respuesta: A**

Patología de la Aorta: Disección Aórtica Aguda & Aneurisma de Aorta Abdominal

1.01.1.023, 1.01.1.024 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

Toda Disección Aórtica Stanford A (que compromete la aorta ascendente) es una emergencia quirúrgica absoluta que exige resolución quirúrgica inmediata a tórax abierto para reemplazar el segmento disecado y evitar la muerte por rotura intrapericárdica, taponamiento o infarto masivo.

PREGUNTA 88 **Respuesta: A**

Patología de la Aorta: Disección Aórtica Aguda & Aneurisma de Aorta Abdominal

1.01.1.023, 1.01.1.024 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

El umbral de diámetro para indicar la reparación quirúrgica profiláctica o endovascular (EVAR) de un aneurisma de aorta abdominal en hombres es de ≥ 5.5 cm (o ≥ 5.0 cm en mujeres), dado que sobre este tamaño el riesgo anual de rotura fatal supera los riesgos inherentes al procedimiento quirúrgico.

PREGUNTA 89 **Respuesta: A**

Tromboembolismo Pulmonar (TEP) & Trombosis Venosa Profunda (TVP)

1.01.1.026, 1.01.2.008 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

En pacientes con probabilidad clínica ALTA de TEP (Wells > 4 o > 6 según escala), el Dímero D carece de utilidad diagnóstica porque un valor normal no permite descartar con seguridad la patología. Se debe proceder de inmediato a la prueba confirmatoria estándar de oro que es el AngioTAC de Arterias Pulmonares.

PREGUNTA 90 **Respuesta: A**

Tromboembolismo Pulmonar (TEP) & Trombosis Venosa Profunda (TVP)

1.01.1.026, 1.01.2.008

Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

GES

La presencia de hipotensión sostenida o shock en un paciente con TEP define a un TEP Masivo o de Alto Riesgo Vital por claudicación del ventrículo derecho. La indicación mandataria de emergencia es la reperfusión farmacológica mediante Fibrinólisis Sistémica con Alteplasa (rt-PA 100 mg EV) para lisar el trombo y desobstruir el lecho vascular pulmonar.